CONFERENCE 2.8

Processus obstructif

PREVENTION



Le tutorat du Cesir vous propose cette conférence sur l'UE 2.8 - Processus obstructifs.
Cette conférence peut contenir des erreurs, si tel est le cas nous nous en excusons par avance et nous vous encourageons à nous envoyer un message privé sur le compte instagram: @Cesirevise ou alors de nous envoyer un mail au : tutorat.cesirevise@gmail.com

Nous vous rappelons aussi que nous sommes étudiants comme vous et que nous créons ces conférences espendant notre temps libre. Nous faisons de notre mieux pour faire le moins d'erreurs possibles et de vous proposez un contenu de qualité.

Cette conférence ne remplace en aucun cas les cours de l'IFSI, elles servent de complément. Cette conference ne sert en aucun cas d'évaluation blanche comme vous avez pu avoir par l'IFSI.

- L'équipe Tutorat du CESIR

CAS CONCRET 1

Monsieur X, 56 ans, est hospitalisé le 17 mars dans un service de cardiologie pour une coronarographie par voie fémorale prévue le lendemain.
Il est muté d'un hôpital de la périphérie de Lyon où il a été admis le 12 mars 2012 pour un infarctus du myocarde
Ses antécédents sont :

- Hypertension artérielle depuis 10 ans

A son arrivée, ses traitements sont :

- LASILIX® (Furosémide - Diurétique) 40 mg, un comprimé par jour.
- MOPRAL® (Oméprazole – Antisécrétoire gastrique) 20 mg, une gélule par jour.
- TRIATEC® (Ramipril – IEC-antihypertenseur) 2.5 mg un comprimé par jour
- LOVENOX® (HBPM - Anticoagulant) 0.4mL à 18 h.
- SECTRAL ® (Acébutolol - Bêtabloquant) : 200 mg par jour.

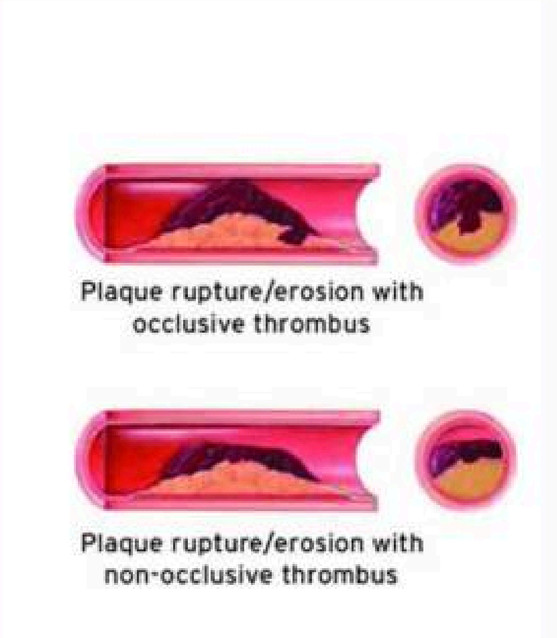
Le jour de son examen, un cathéter périphérique au bras droit lui est posé.

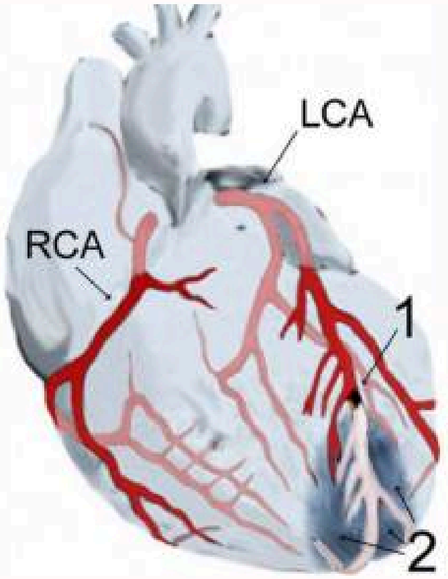
1) Définissez l'IDM et expliquez son processus physiopathologique.
2) Citez et expliquez les risques encourus par Mr X au retour de sa coronarographie.

CAS CONCRET 1

1) Définissez l'IDM et expliquez son processus physiopathologique.

l'Infarctus du myocarde désigne la mort des cellules myocardiques par ischémie prolongée d'une artère coronaire, généralement causée par un thrombus, une plaque d'atherome ou une embole.





CAS CONCRET 1

2) Citez et expliquez les risques encourus par Mr X au retour de sa coronarographie.

- Risque hémorragique lié à la ponction d'un vaisseau artériel et à une compression insuffisante
- Risque thromboembolique : risque de migration artérielle d'un embole et risque de thrombose fémorale
- Risque de trouble du rythme lié au cathétérisme des coronaires.
- Risque infectieux au niveau du cathéter périphérique et du point de ponction fémoral
- Risque d'altération de la fonction rénale liée à une intolérance du produit de contraste injecté
- Risque de récidive d'infarctus du myocarde

CAS CONCRET 2

Mme X, 65 ans, hospitalisée en gynécologie, vient de subir une hystérectomie pour fibrome important dans l'utérus.

A J2 de son intervention, elle vous dit qu'elle 'se sent légèrement essoufflée' après avoir réalisé sa toilette et qu'elle ressent une légère douleur à l'inspiration profonde. Mme X. vous confie qu'à l'âge de 35 ans, elle a eu une phlébite à la suite d'une césarienne. Elle vous confie aussi avoir été une fumeuse régulière fut un temps (10 paquets par semaine).
En faisant vos recherches vous remarquez qu'elle souffre depuis des années d'insuffisance veineuse et présente de nombreuses petites varices aux membres inférieurs. A l'observation des MI, l'IDE constate une légère rougeur du mollet droit. Sa température est de 37,9°C et son rythme cardiaque est à 140 pulsations par minute.

1. Indiquez les facteurs prédisposants et les facteurs précipitants chez Mme X. d'une potentielle TVP ou EP
2. Indiquez les signes cliniques présents chez Mme X pouvant indiquer une TVP et/ou une EP.

CAS CONCRET 2

1. Indiquez les facteurs prédisposants et les facteurs précipitants chez Mme X. d'une potentielle TVP ou EP

Facteurs prédisposants :

- Âge > 60 ans
- Antécédent personnel de phlébite (à 35 ans après césarienne)
- Insuffisance veineuse chronique, varices
- Tabagisme antérieur
- Immobilisation antérieure prolongée (si applicable)

Facteurs précipitants :

- Chirurgie récente : hystérectomie → immobilisation postopératoire, stress chirurgical
- Alitement / réduction de la mobilité à J2 postopératoire
- Inflammation postopératoire (réaction tissulaire après chirurgie)

CAS CONCRET 2

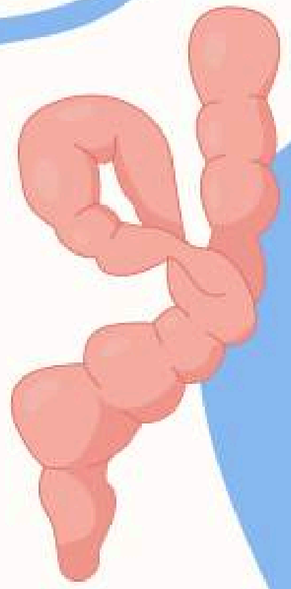
2) Indiquez les signes cliniques présents chez Mme X pouvant indiquer une TVP et/ou une EP.

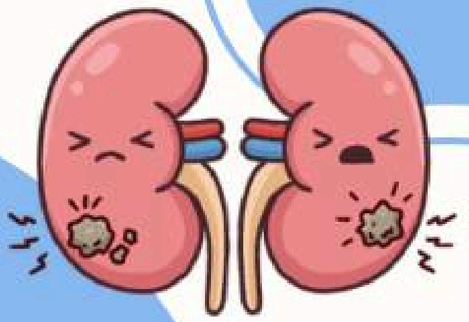
TVP:

- Rougeur du mollet droit
- Douleur à la palpation ou gêne dans le mollet
- Légère tuméfaction (si présente)

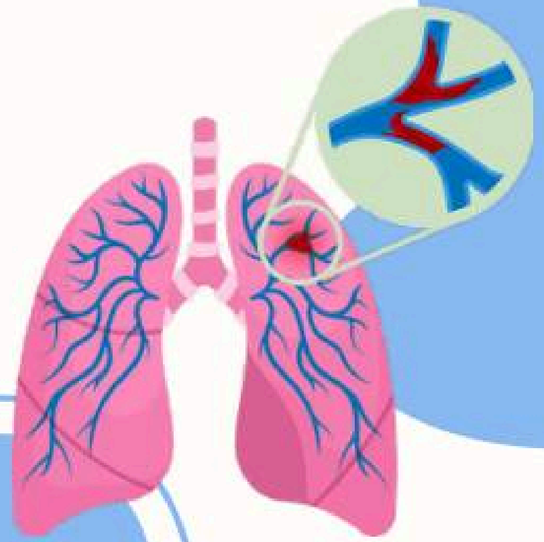
EP:

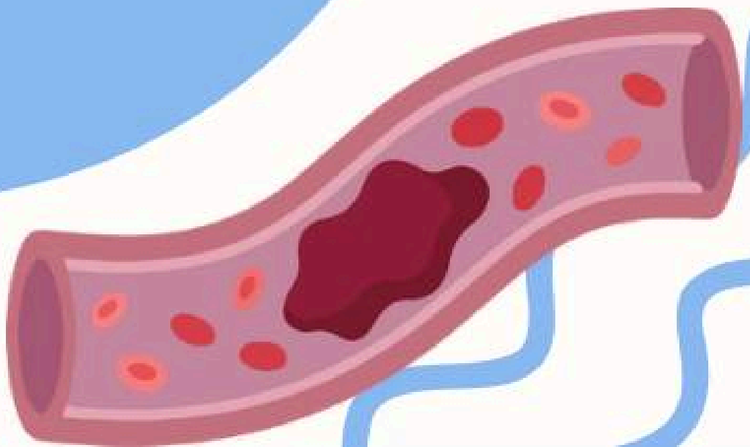
- Dyspnée / essoufflement à l'effort ou au repos
- Douleur thoracique à l'inspiration (pleurétique)
- Tachycardie : 140 bpm
- Fièvre légère : 37,9°C



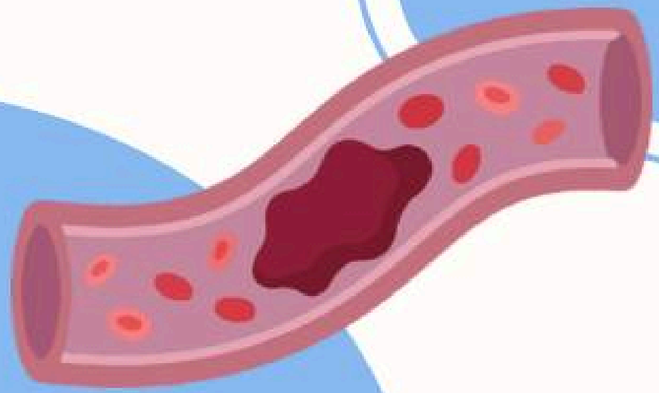


QCM !!!!!!!!

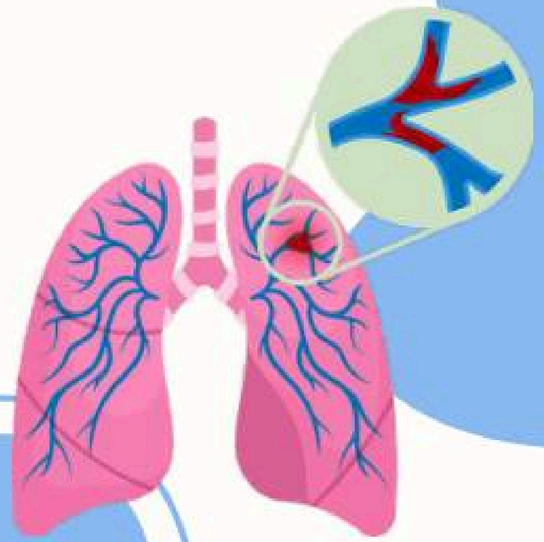


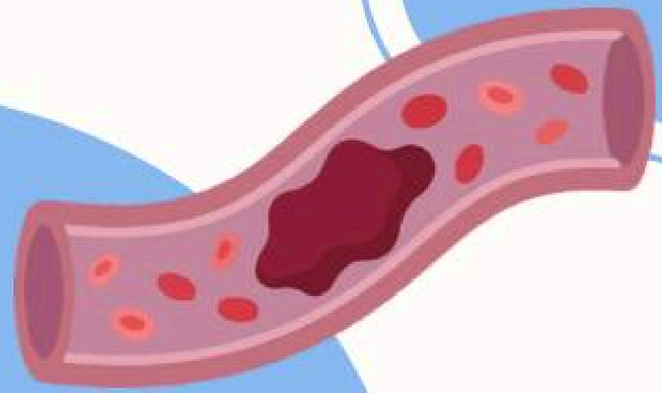


AVC

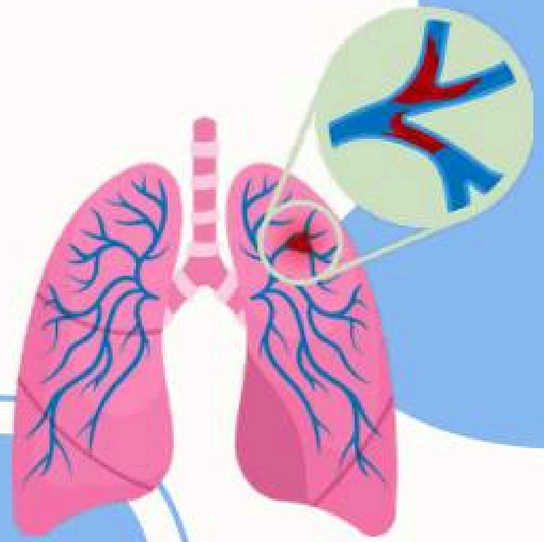


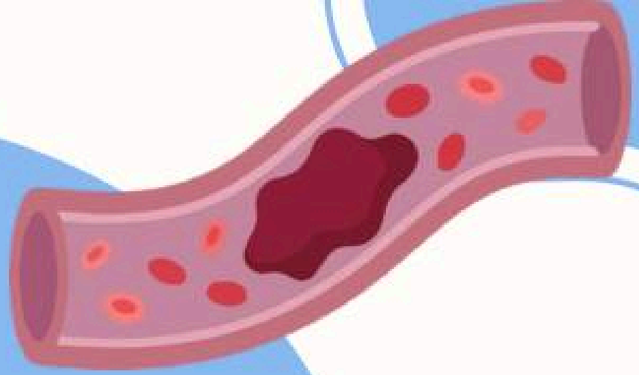
- ISCHÉMIQUE / HÉMMORAGIQUE
- THROMBOLYSE (4H30) & THROMBECTOMIE (6H)
- DIAG : FAST / SCAN / IRM
- FDRCV ≠ FDR AVC (HTA, FA, CHOLESTÉROL, TABAC, OH, OBÉSITÉ, ÂGE AVANCÉE, CO, MÉNOPAUSE, SAOS...)
- CAUSES MULTIPLES





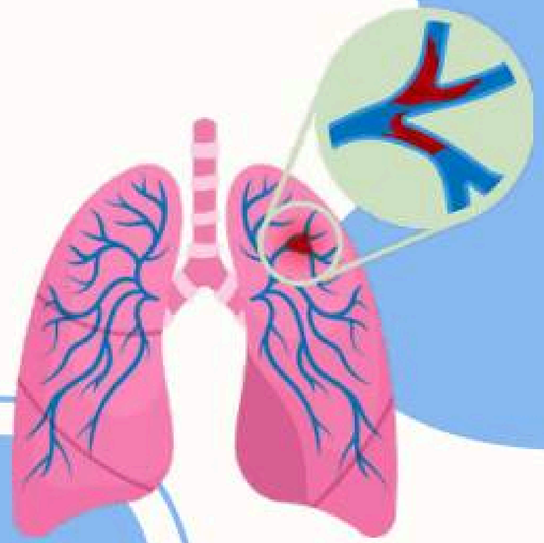
TRHOMBOSE VEINEUSE PROFONDE ET EMBOLIE PULMONAIRE

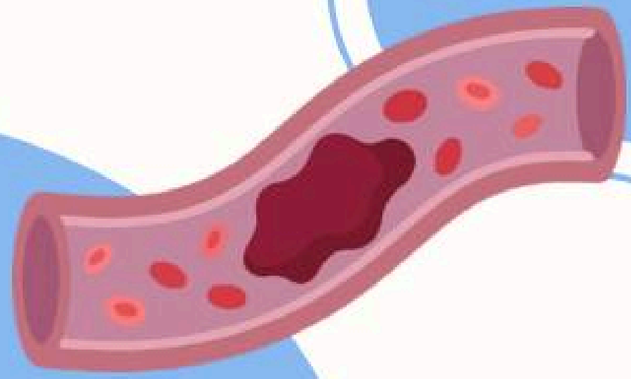




1) LORS D'UN TVP, L'INFIRMIER(ÈRE) PEUT AUTORISER LA PERSONNE À SE LEVER UNE FOIS QUE LA THÉRAPEUTIQUE ANTICOAGULANTE A ÉTÉ DÉMARRÉE.

A - VRAI
B - FAUX

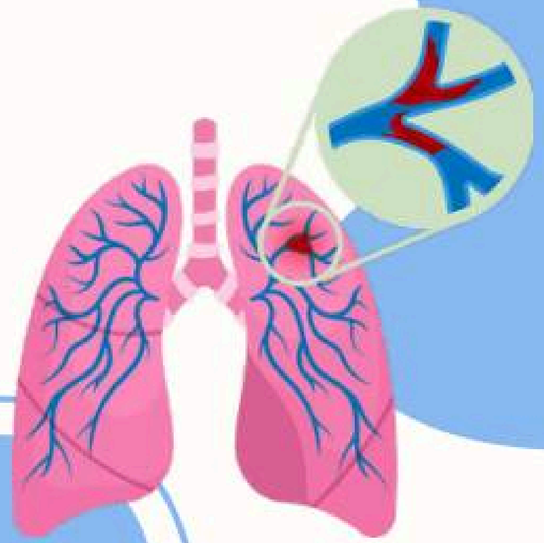


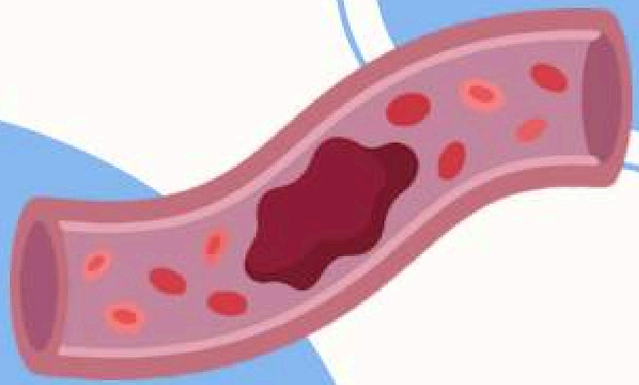


1) LORS D'UN TVP, L'INFIRMIER(ÈRE) PEUT AUTORISER LA PERSONNE À SE LEVER UNE FOIS QUE LA THÉRAPEUTIQUE ANTICOAGULANTE A ÉTÉ DÉMARRÉE.

A - VRAI

B - FAUX

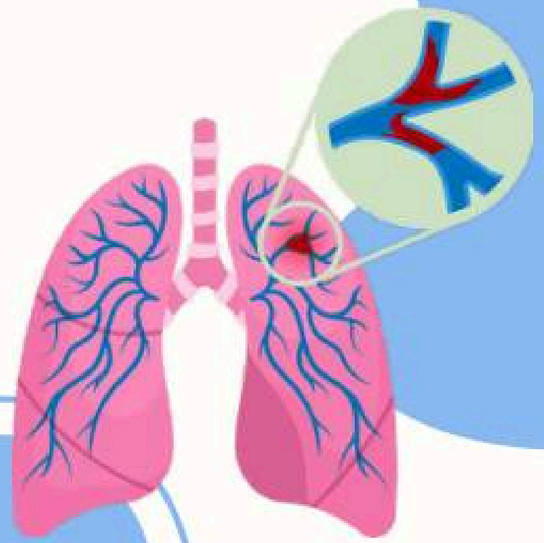


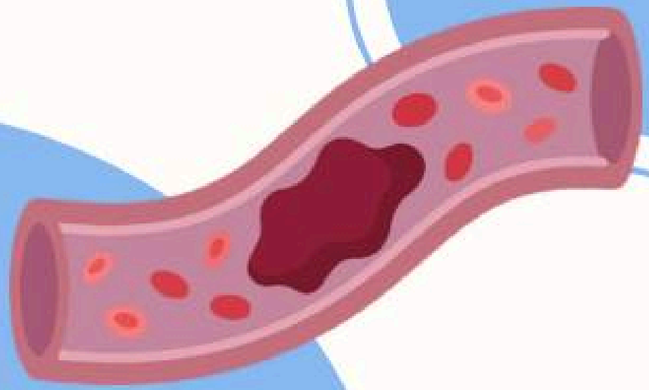


2) L'EMBOLIE PULMONAIRE EST DUE À :

1.

A - L'OBSTRUCTION D'UNE ARTÈRE PULMONAIRE
B - L'OBSTRUCTION D'UNE VEINE PULMONAIRE
C - L'OBSTRUCTION D'UNE ARTÈRE CORONAIRE





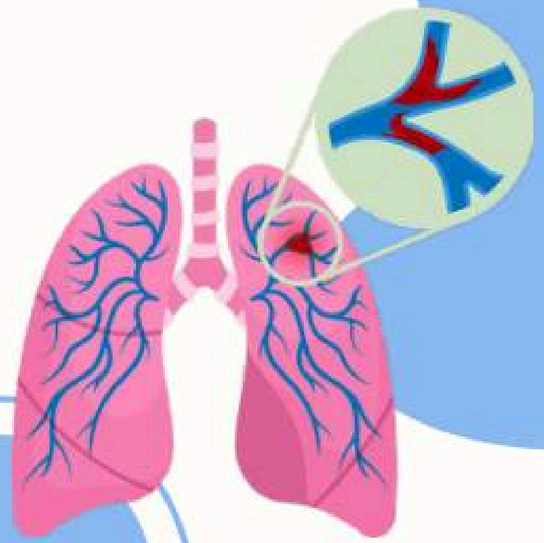
2) L'EMBOLIE PULMONAIRE EST DUE À :

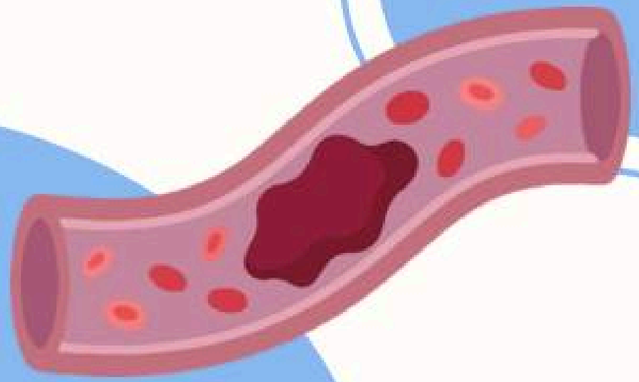
1.

A - L'OBSTRUCTION D'UNE ARTÈRE PULMONAIRE

B - L'OBSTRUCTION D'UNE VEINE PULMONAIRE

C - L'OBSTRUCTION D'UNE ARTÈRE CORONAIRE

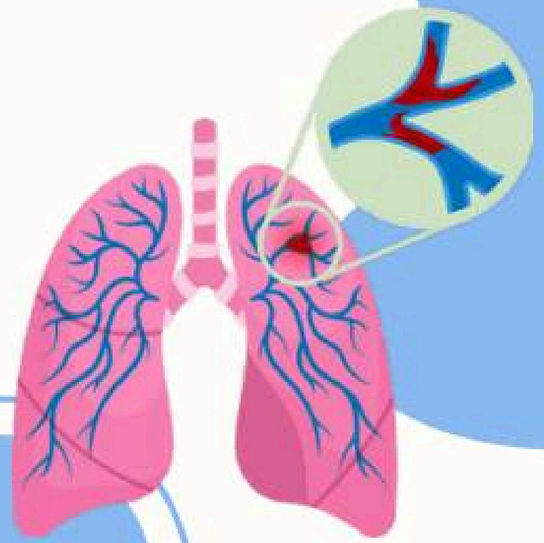


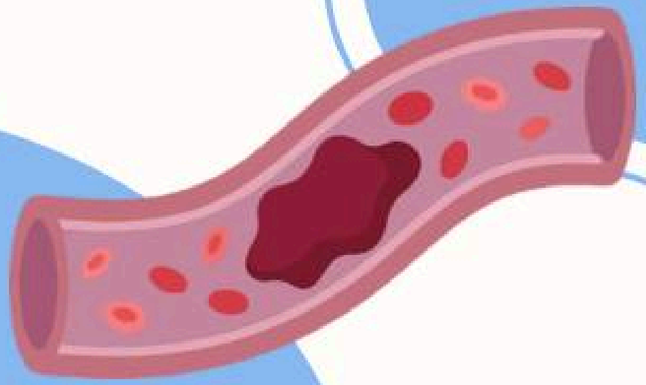


2.

A - PAR UN THROMBUS PROVENANT DE LA CIRCULATION ARTÉRIELLE

B - PAR UN THROMBUS PROVENANT DE LA CIRCULATION VEINEUSE

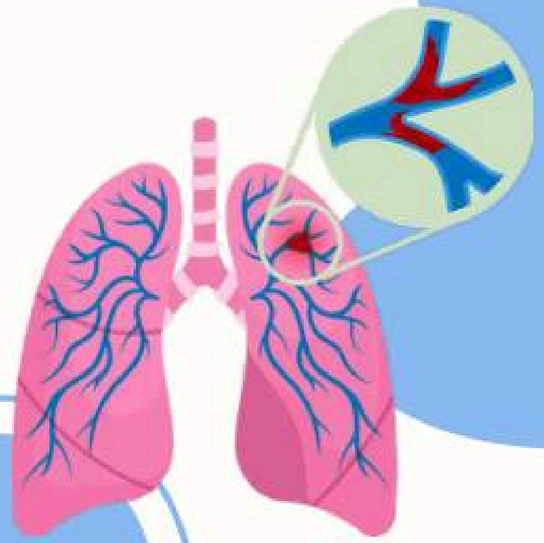


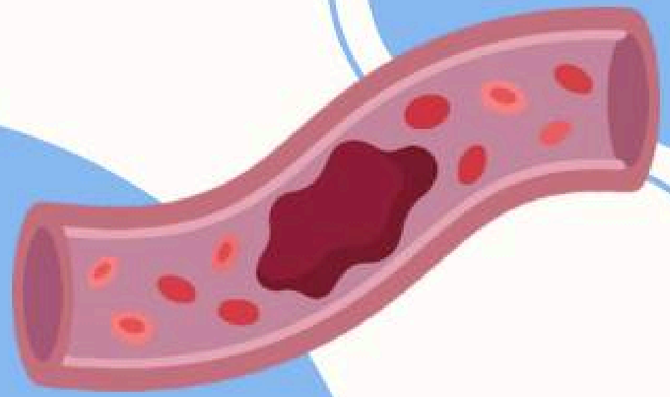


2.

A - PAR UN THROMBUS PROVENANT DE LA CIRCULATION ARTÉRIELLE

B - PAR UN THROMBUS PROVENANT DE LA CIRCULATION VEINEUSE

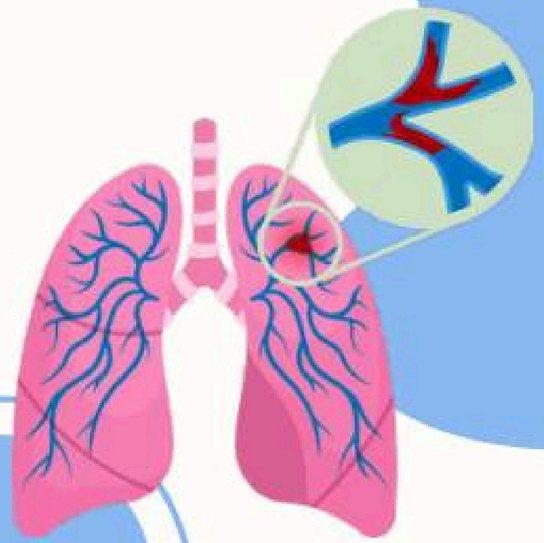


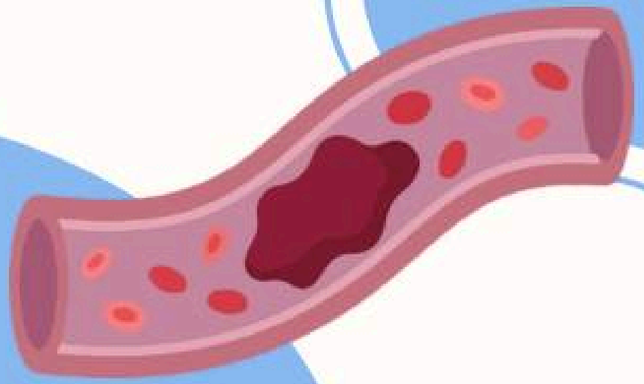


3.

A - MIGRANT DANS LA VCI, L'ATRIUM DROIT, LE VENTRICULE DROIT ET L'ARTÈRE PULMONAIRE

B - MIGRANT DANS LA VCI, L'ATRIUM GAUCHE, LE VENTRICULE GAUCHE ET L'ARTÈRE PULMONAIRE

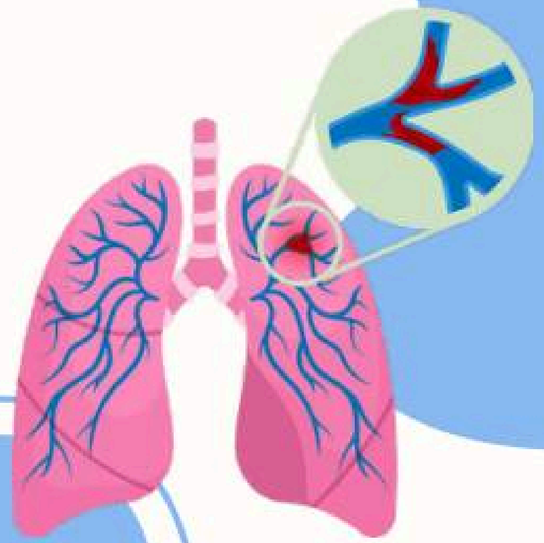


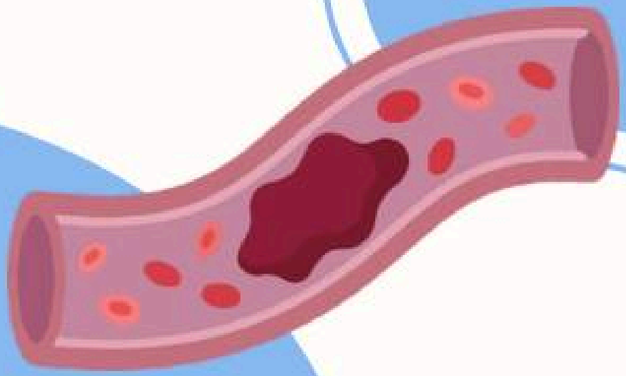


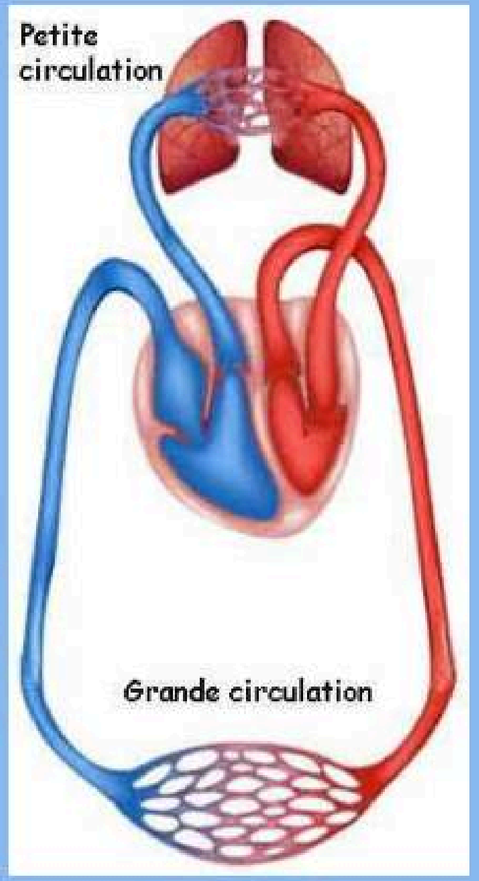
3.

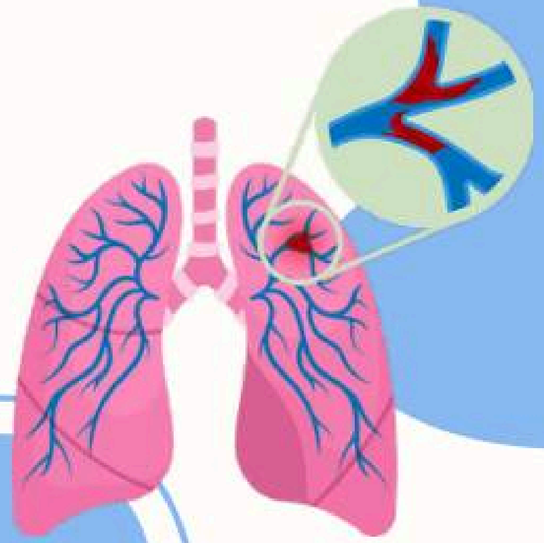
A - MIGRANT DANS LA VCI, L'ATRIUM DROIT, LE VENTRICULE DROIT ET L'ARTÈRE PULMONAIRE

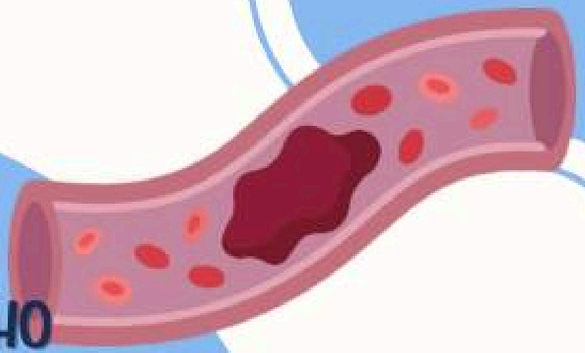
B - MIGRANT DANS LA VCI, L'ATRIUM GAUCHE, LE VENTRICULE GAUCHE ET L'ARTÈRE PULMONAIRE





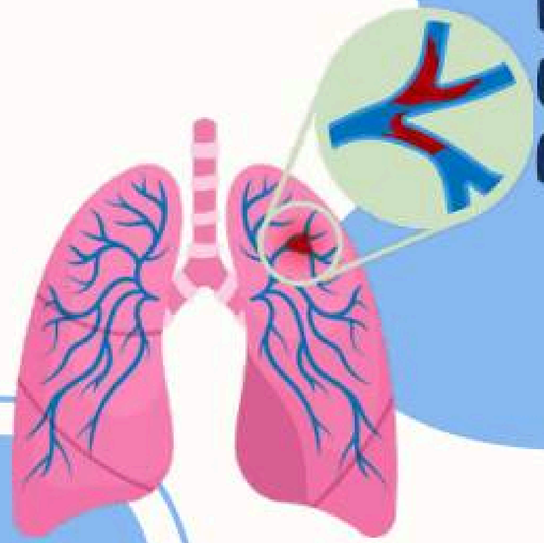

Petite
circulation
Grande circulation

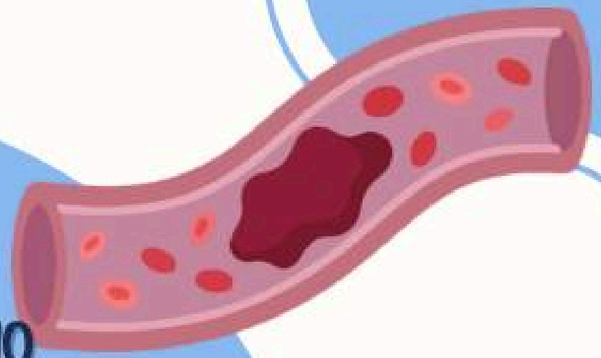




3)UNE PHLÉBITE SURALE DROITE CONFIRMÉE PAR ÉCHO DOPPLER IMPLIQUE :

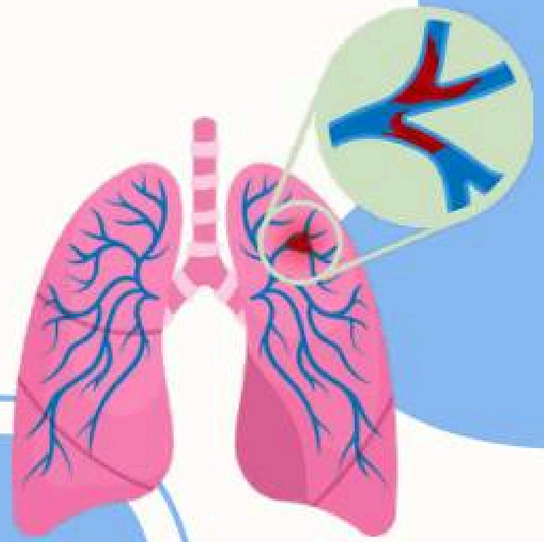
A - LE PORT DE BAS DE CONTENTION
B - UNE VEINE SURALE DROITE LIBRE ET COMPRESSIBLE
C - UN LEVER IMMÉDIAT
D - UNE POSITION ASSISE, AU BORD DU LIT, LES JAMBES PENDANTES
E - UN TRAITEMENT PAR HÉPARINE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE AVEC RELAIS PAR ANTI VITAMINE K

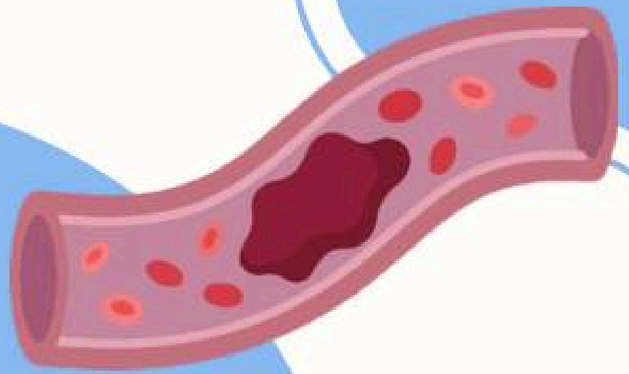




3)UNE PHLÉBITE SURALE DROITE CONFIRMÉE PAR ÉCHO DOPPLER IMPLIQUE :

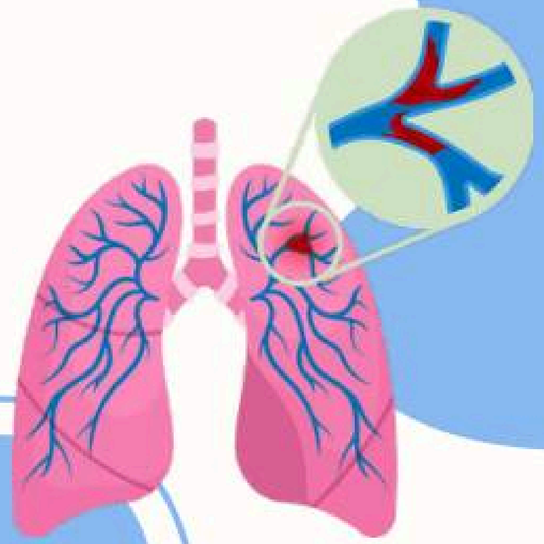
A - LE PORT DE BAS DE CONTENTION
B - UNE VEINE SURALE DROITE LIBRE ET COMPRESSIBLE
C - UN LEVER IMMÉDIAT
D - UNE POSITION ASSISE, AU BORD DU LIT, LES JAMBES PENDANTES
E - UN TRAITEMENT PAR HÉPARINE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE AVEC RELAIS PAR ANTI VITAMINE K

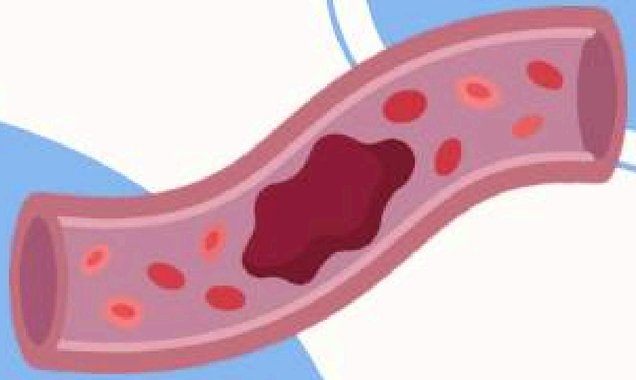




4) LES SIGNES CLINIQUES FAISANT SUSPECTER UNE EMBOLIE PULMONAIRE SONT :

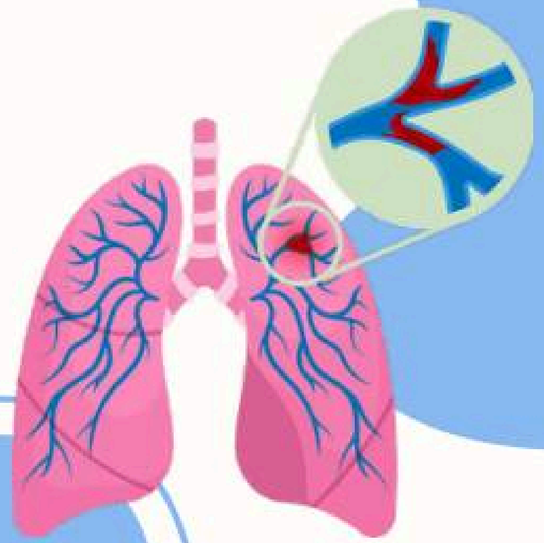
A - L'HYPOXIE
B - LA TACHYCARDIE
C - LA BRADYPNÉE
D - LA BRADYCARDIE
E - L'HÉMOPTYSIE

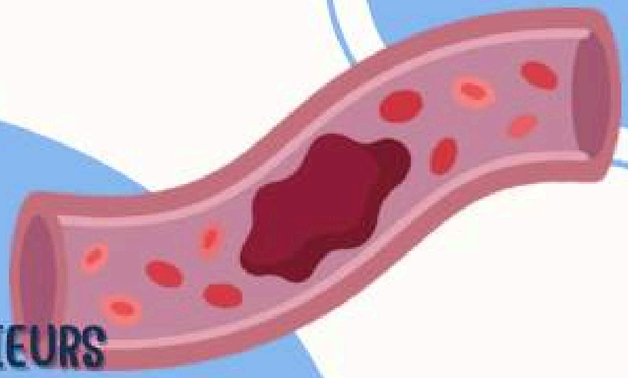




4) LES SIGNES CLINIQUES FAISANT SUSPECTER UNE EMBOLIE PULMONAIRE SONT :

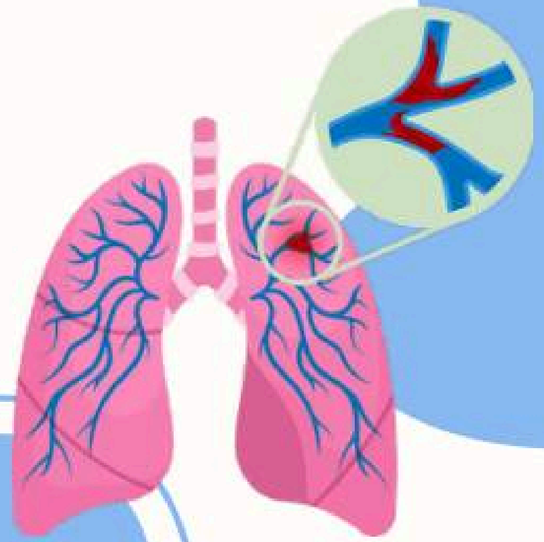
A - L'HYPOXIE
B - LA TACHYCARDIE
C - LA BRADYPNÉE
D - LA BRADYCARDIE
E - L'HÉMOPTYSIE

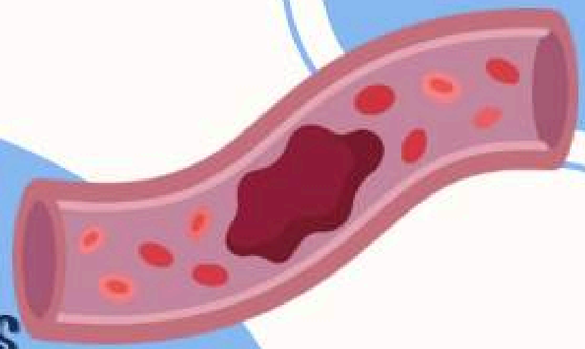




5) L'ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS (AOMI) ÉVOLUE VERS :

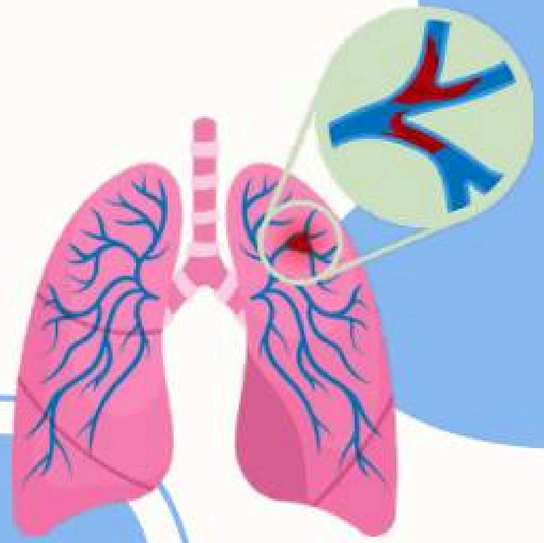
A - UNE BAISSE DE LA PERFUSION DU MEMBRE INFÉRIEUR À L'EFFORT
B - UNE CRAMPE DOULOUREUSE À L'EFFORT
C - UNE AUGMENTATION DE LA PERFUSION DU MEMBRE INFÉRIEUR
D - UNE CLAUDICATION INTERMITTENTE
E - UNE OBSTRUCTION COMPLÈTE DE L'ARTÈRE

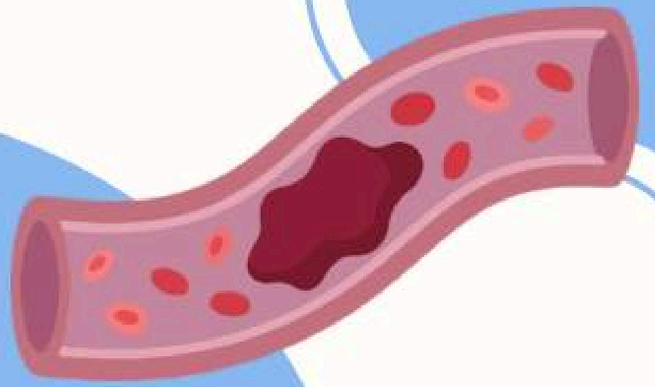




5) L'ARTÉRITE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS (AOMI) ÉVOLUE VERS :

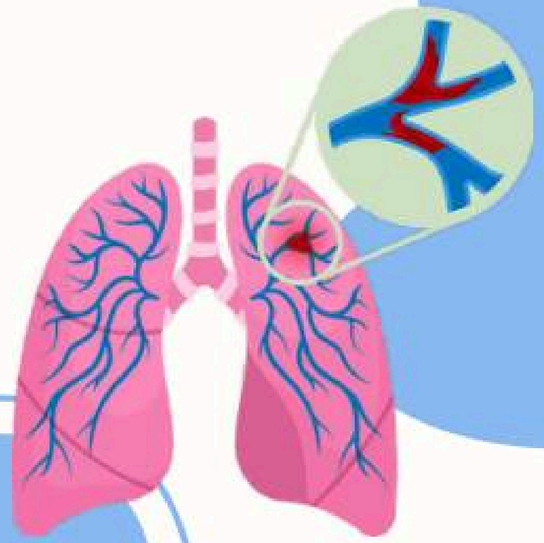
A - UNE BAISSE DE LA PERFUSION DU MEMBRE INFÉRIEUR À L'EFFORT
B - UNE CRAMPE DOULOUREUSE À L'EFFORT
C - UNE AUGMENTATION DE LA PERFUSION DU MEMBRE INFÉRIEUR
D - UNE CLAUDICATION INTERMITTENTE
E - UNE OBSTRUCTION COMPLÈTE DE L'ARTÈRE

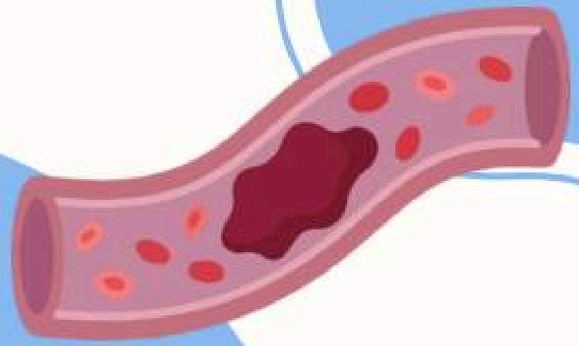




6) LES COMPLICATIONS DE L'ARTÉRITE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS (AOMI) SONT :

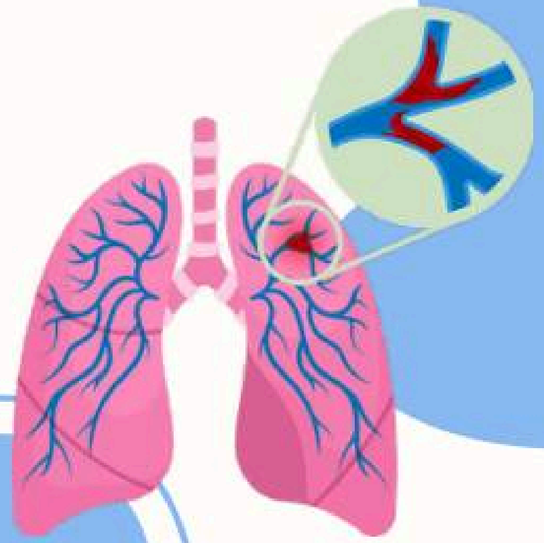
A - UNE THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE
B - L'ISCHÉMIE AIGUË
C - L'HÉMORRAGIE
D - LE RETARD DE CICATRISATION D'UNE PLAIE
E - L'INFECTION

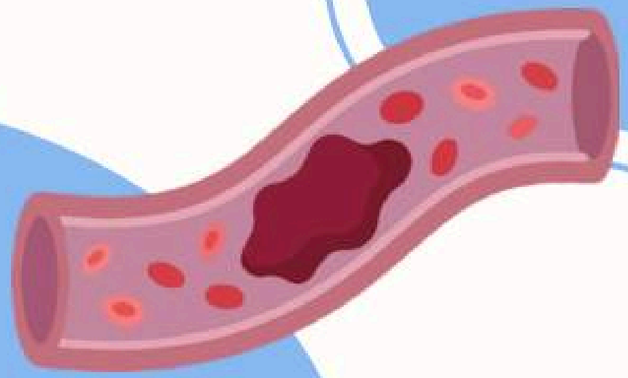




6) LES COMPLICATIONS DE L'ARTÉRITE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS (AOMI) SONT :

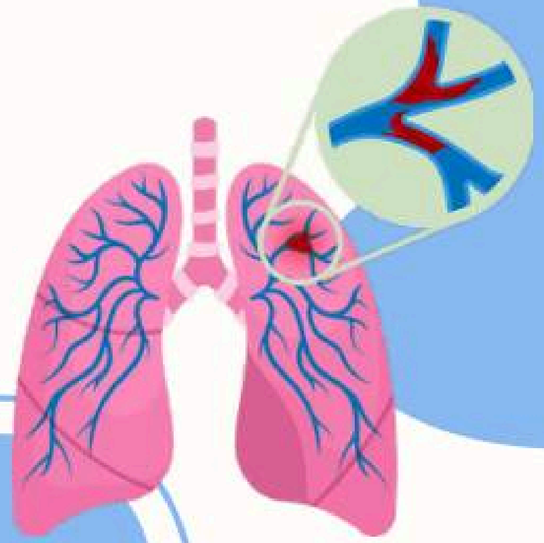
A - UNE THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE
B - L'ISCHÉMIE AIGUË
C - L'HÉMORRAGIE
D - LE RETARD DE CICATRISATION D'UNE PLAIE
E - L'INFECTION

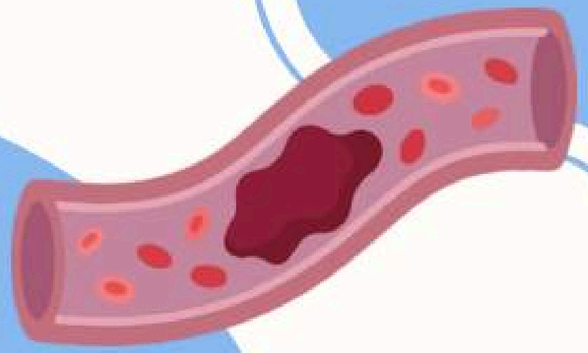




7) UN DIAGNOSTIC POSITIF DE D DIMÈRES :

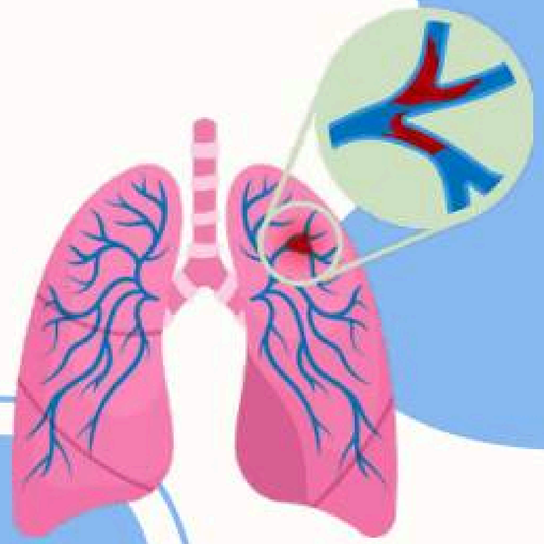
A - AFFIRME LE DIAGNOSTIC D'INFARCTUS DU MYOCARDE
B - AFFIRME LE DIAGNOSTIC D'EMBOLIE PULMONAIRE
C - RÉCUSE LE DIAGNOSTIC D'EMBOLIE PULMONAIRE
D - AFFIRME LE DIAGNOSTIC D'ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
E - AUCUNE DES RÉPONSES CI-DESSUS N'EST EXACTE

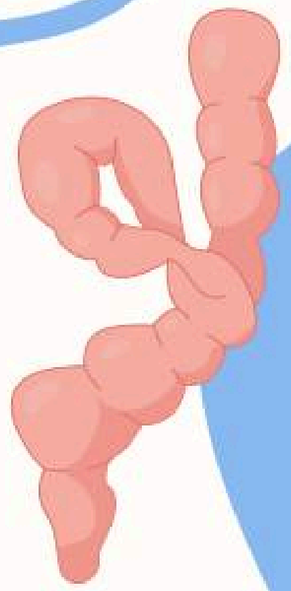


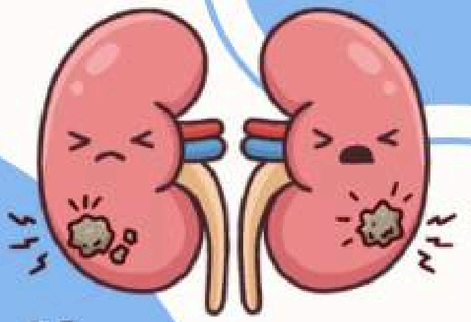


7) UN DIAGNOSTIC POSITIF DE D DIMÈRES :

A - AFFIRME LE DIAGNOSTIC D'INFARCTUS DU MYOCARDE
B - AFFIRME LE DIAGNOSTIC D'EMBOLIE PULMONAIRE
C - RÉCUSE LE DIAGNOSTIC D'EMBOLIE PULMONAIRE
D - AFFIRME LE DIAGNOSTIC D'ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
E - AUCUNE DES RÉPONSES CI-DESSUS N'EST EXACTE

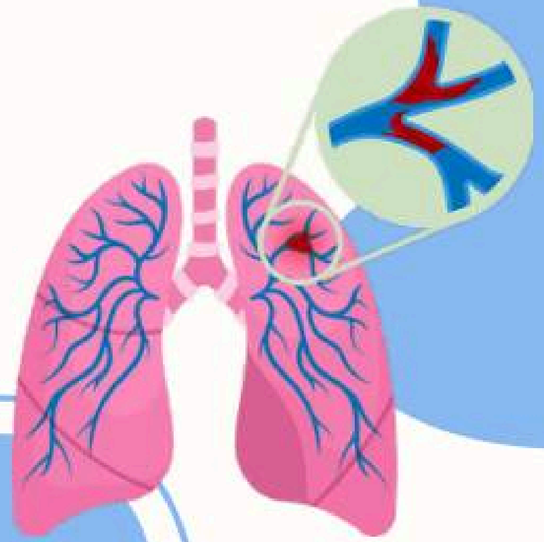


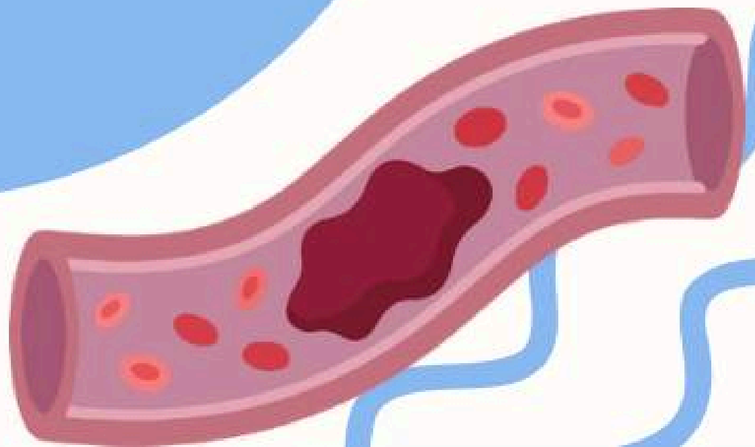


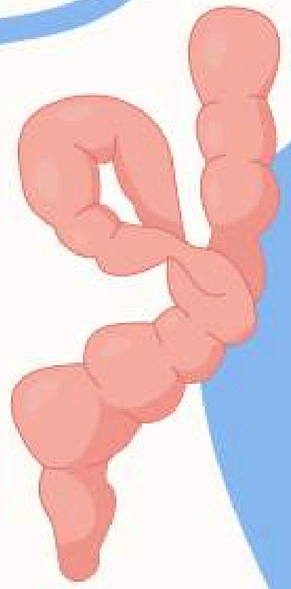


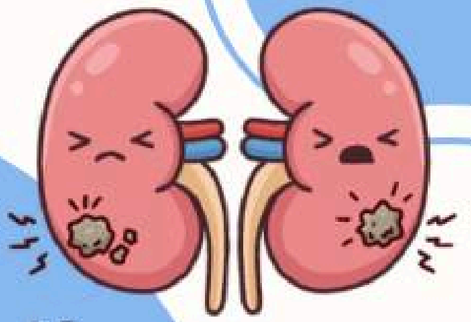
8) LORSQUE L'INR D'UN PATIENT EST SUPÉRIEURE À 4, LE RISQUE ENCOURU EST :

A - EMBOLIGÈNE
B - INFECTIEUX
C - HYPERTENSION ARTÉRIELLE
D - HÉMORRAGIQUE
E - INSUFFISANCE RÉNALE



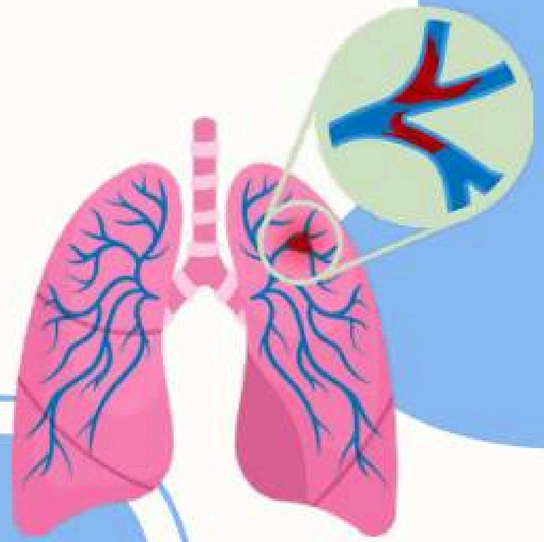


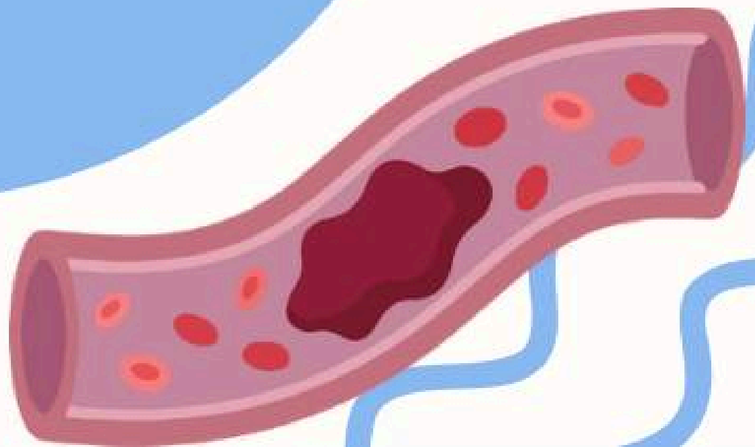




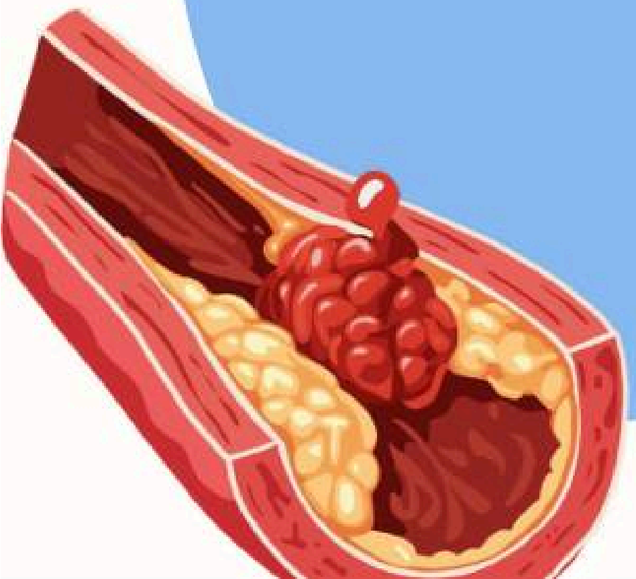
8) LORSQUE L'INR D'UN PATIENT EST SUPÉRIEURE À 4, LE RISQUE ENCOURU EST :

A - EMBOLIGÈNE
B - INFECTIEUX
C - HYPERTENSION ARTÉRIELLE
D - HÉMORRAGIQUE
E - INSUFFISANCE RÉNALE





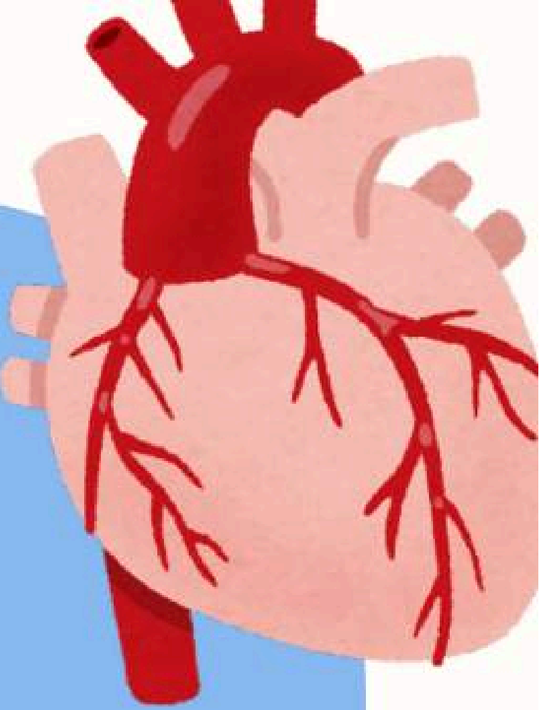
SYNDROME CORONARIEN AIGU



9) DANS LE SCA :

A - LA PLAQUE D'ATHÉROME EST STABLE
B - LA PLAQUE D'ATHÉROME EST FISSURÉE
C - IL Y A CONSTITUTION D'UN THROMBUS





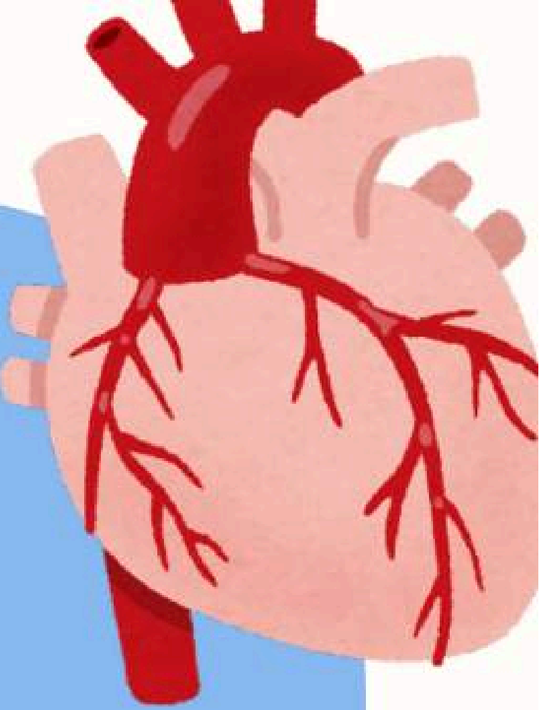
9) DANS LE SCA :

A - LA PLAQUE D'ATHÉROME EST STABLE

B - LA PLAQUE D'ATHÉROME EST FISSURÉE

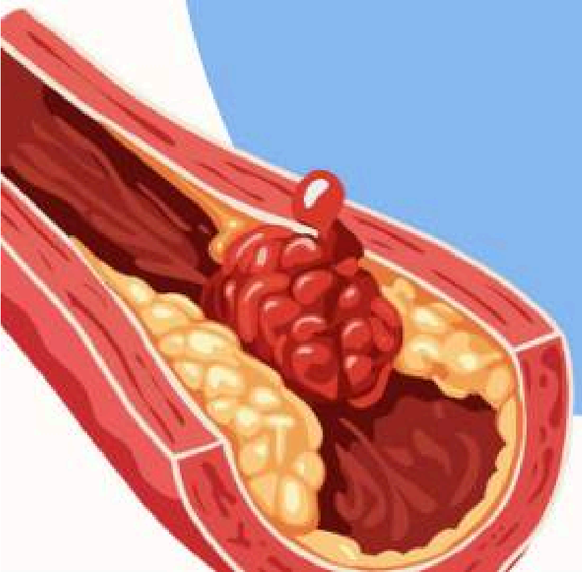
C - IL Y A CONSTITUTION D'UN THROMBUS

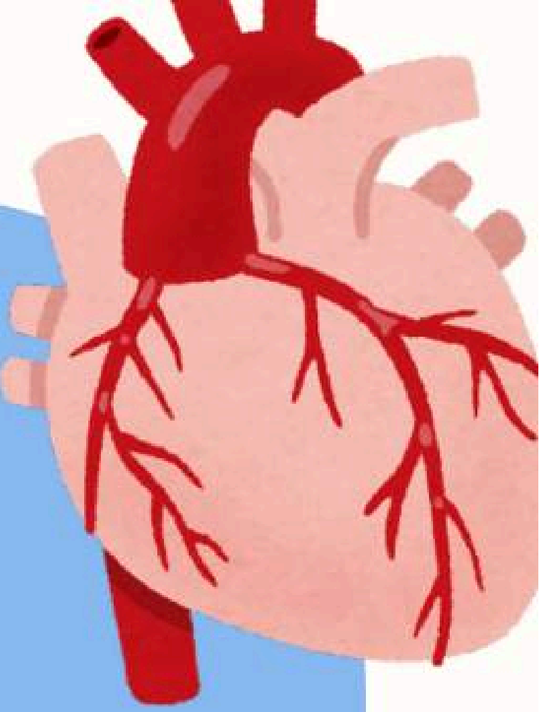




10) LE TRAITEMENT DE LA MALADIE CORONARIENNE COMPREND :

A - UN ANTI VITAMINE K
B - UN DÉRIVÉ NITRÉ
C - DES ANTALGIQUES
D - DES ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES
E - DES BÊTABLOQUANTS





10) LE TRAITEMENT DE LA MALADIE CORONARIENNE COMPREND :

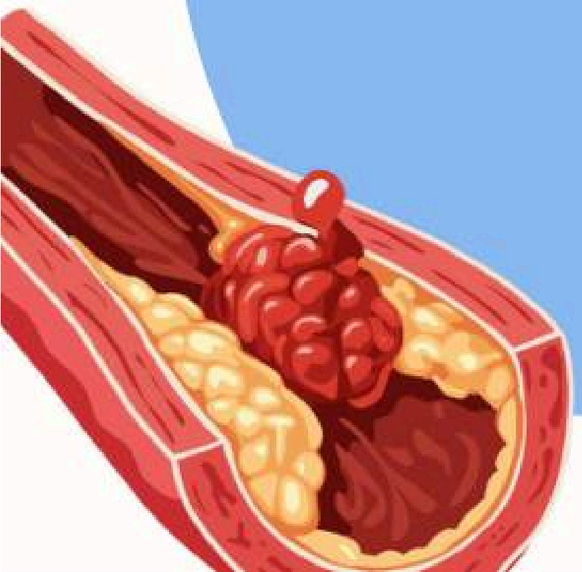
A - UN ANTI VITAMINE K

B - UN DÉRIVÉ NITRÉ

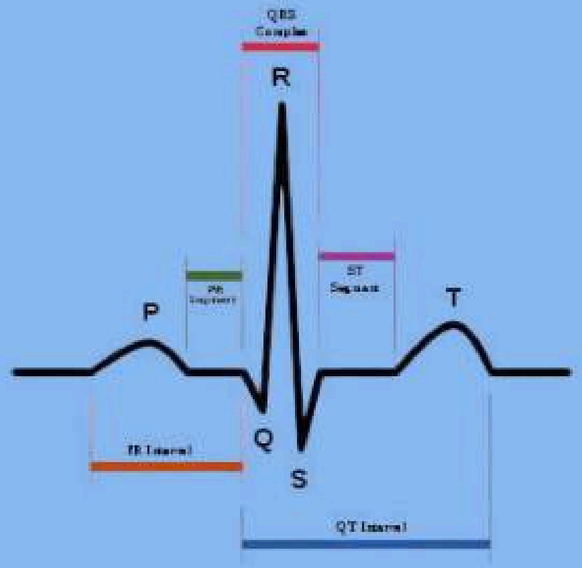
C - DES ANTALGIQUES

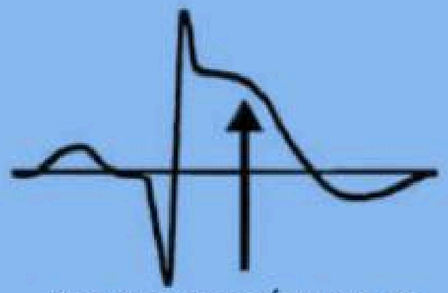
D - DES ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES

E - DES BÊTABLOQUANTS

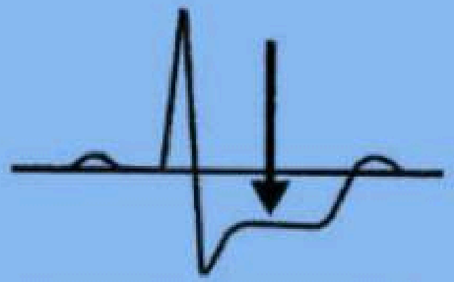


RAPPEL ECG SUR LE SCA ST

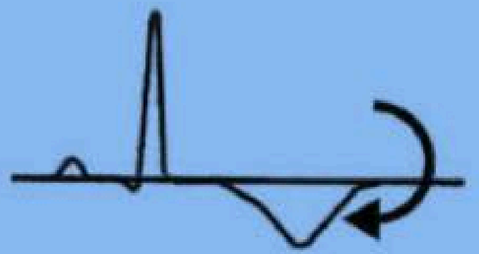




SCA AVEC SUS DÉCALAGE ST



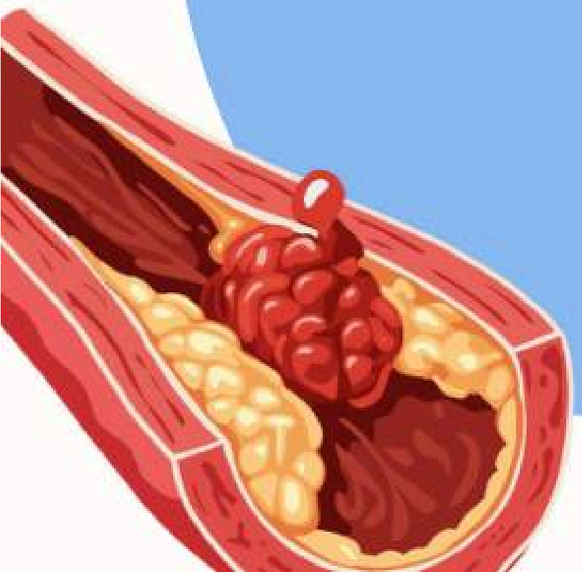
SCA AVEC SOUS DÉCALAGE ST

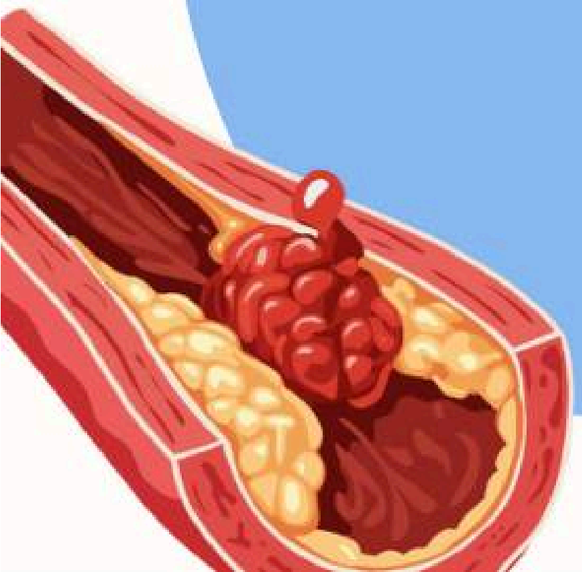


SCA SANS SUS OU SOUS DÉCALAGE, MAIS ONDE T NÉGATIVE

11) L'ENZYME CARDIAQUE DONT L'ÉLÉVATION EST DIRECTEMENT PROPORTIONNELLE À L'IMPORTANCE DE LA SOUFFRANCE ISCHÉMIQUE CARDIAQUE EST :

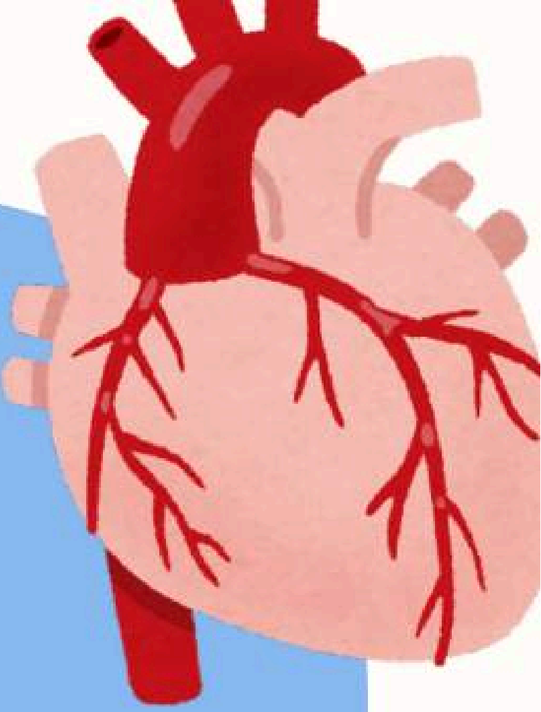
A - LA CRÉATININE
B - LA TROPONINE
C - LE D-DIMÈRE
D - LA GAMMA GT
E - LA G6PD

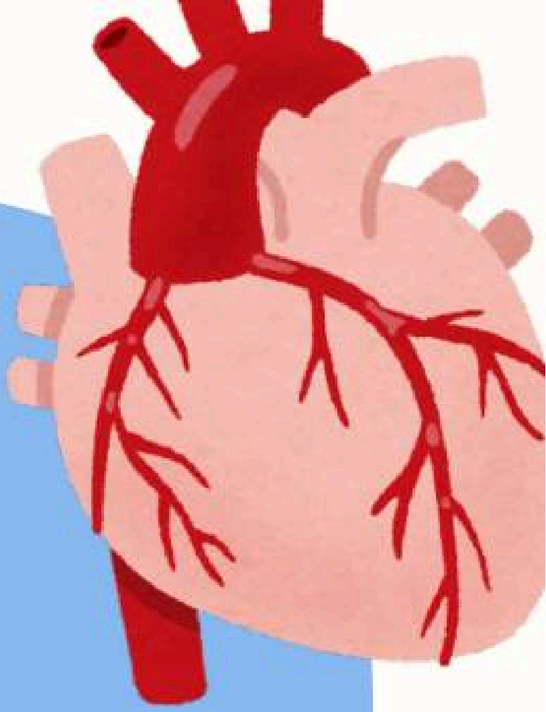




11) L'ENZYME CARDIAQUE DONT L'ÉLÉVATION EST DIRECTEMENT PROPORTIONNELLE À L'IMPORTANCE DE LA SOUFFRANCE ISCHÉMIQUE CARDIAQUE EST :

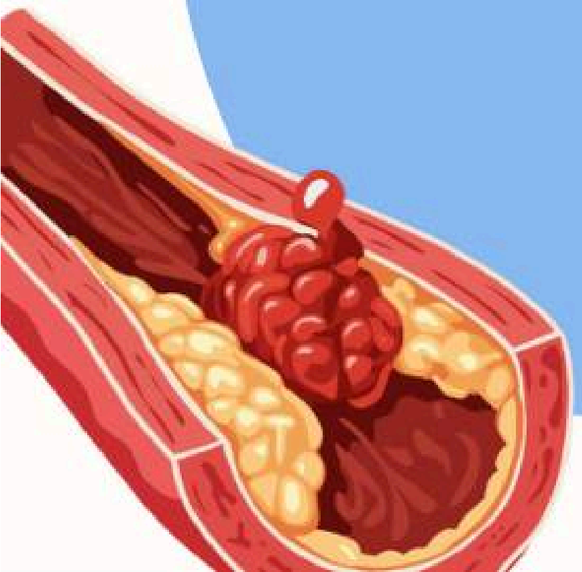
A - LA CRÉATININE
B - LA TROPONINE
C - LE D-DIMÈRE
D - LA GAMMA GT
E - LA G6PD

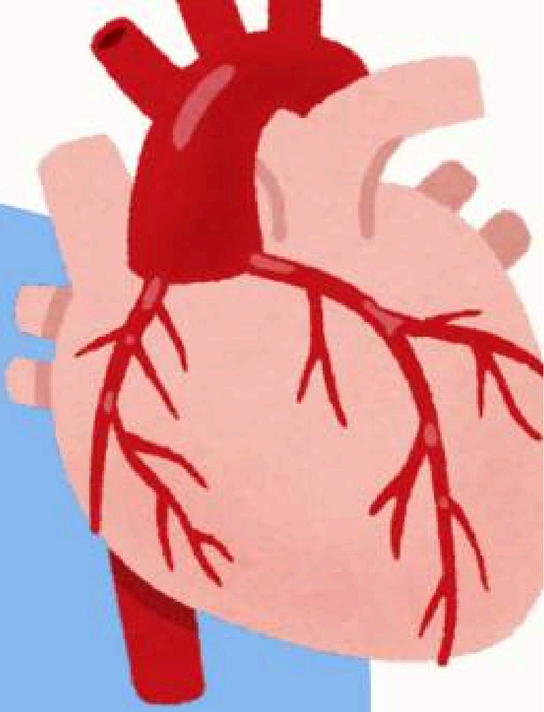




12) LES BÊTABLOQUANTS SONT CONTRE-INDIQUÉS EN CAS DE :

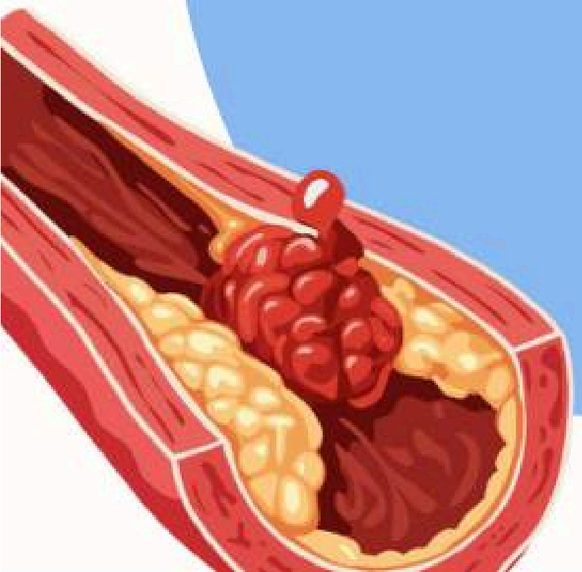
A - PÉRICARDITE
B - INSUFFISANCE CARDIAQUE
C - PÉRITONITE
D - BRADYCARDIE
E - TACHYCARDIE

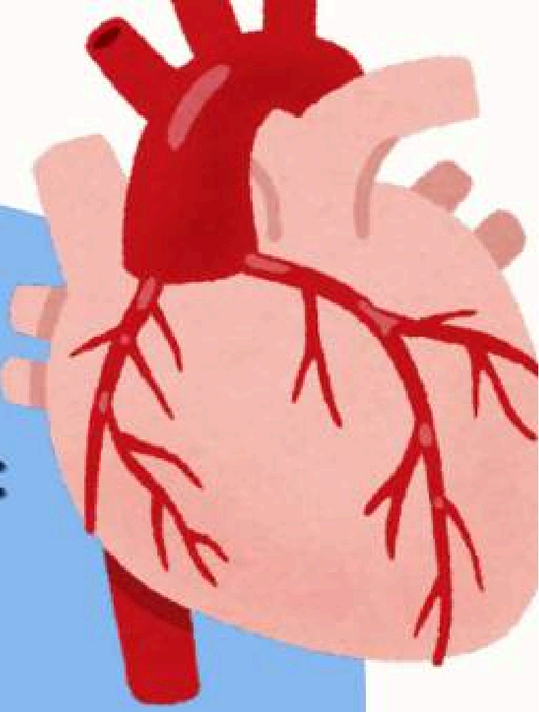




12) LES BÊTABLOQUANTS SONT CONTRE-INDIQUÉS EN CAS DE :

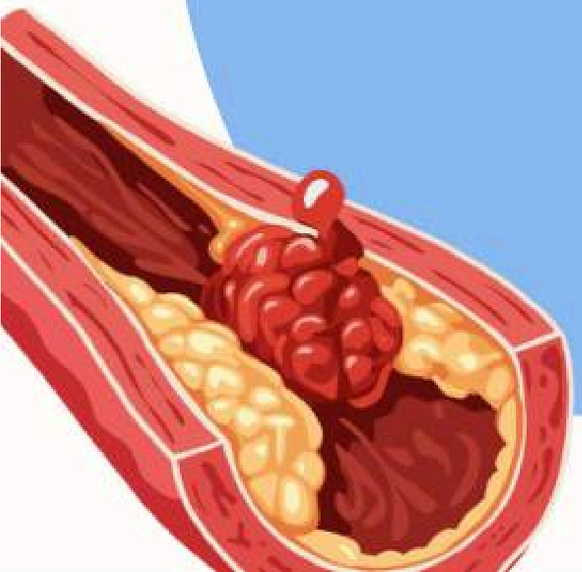
A - PÉRICARDITE
B - INSUFFISANCE CARDIAQUE
C - PÉRITONITE
D - BRADYCARDIE
E - TACHYCARDIE





13) LA PREMIÈRE CAUSE DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE EST:

A - LA FISSURATION D'UNE ARTÈRE CORONAIRE SAINE
B - LA FISSURATION D'UNE PLAQUE D'ATHÉROME SUR UNE ARTÈRE CORONAIRE
C - LA RUPTURE DE LA PAROI MYOCARDIQUE
D - LE SPASME D'UNE ARTÈRE CORONAIRE
E - L'EMBOLISATION APRÈS UNE THROMBOSE VEINEUSE



13) LA PREMIÈRE CAUSE DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE EST:

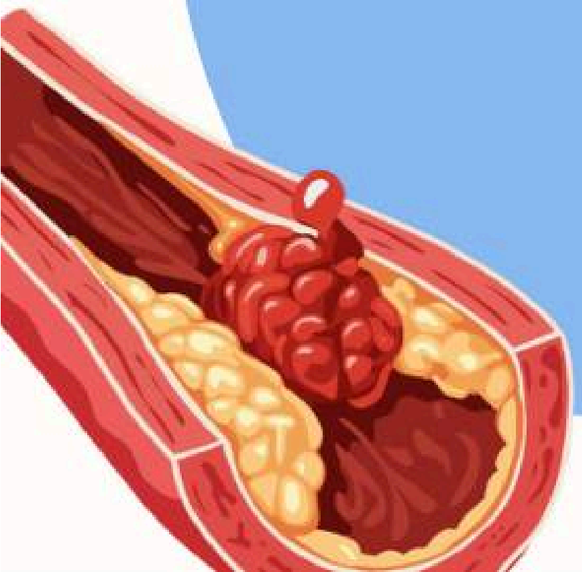
A - LA FISSURATION D'UNE ARTÈRE CORONAIRE SAINE

B - LA FISSURATION D'UNE PLAQUE D'ATHÉROME SUR UNE ARTÈRE CORONAIRE

C - LA RUPTURE DE LA PAROI MYOCARDIQUE

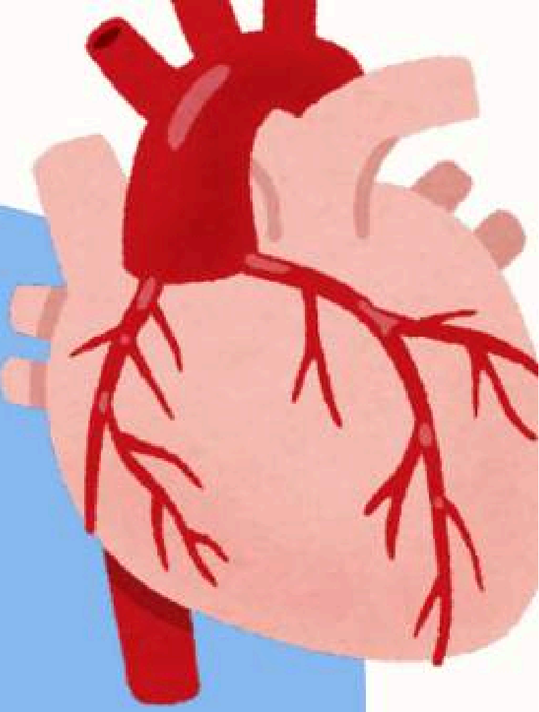
D - LE SPASME D'UNE ARTÈRE CORONAIRE

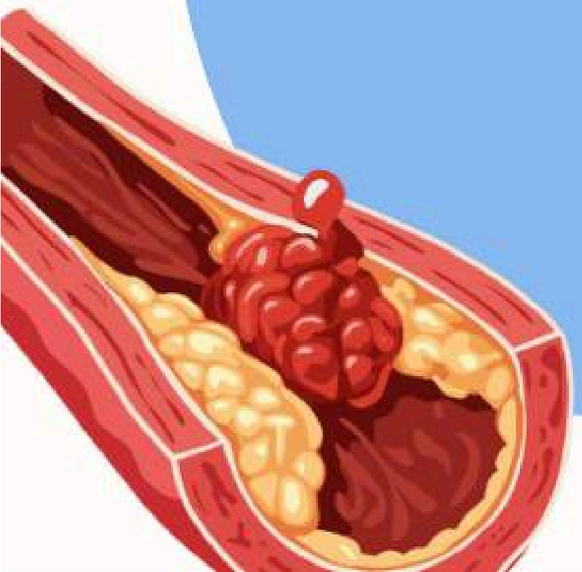
E - L'EMBOLISATION APRÈS UNE THROMBOSE VEINEUSE

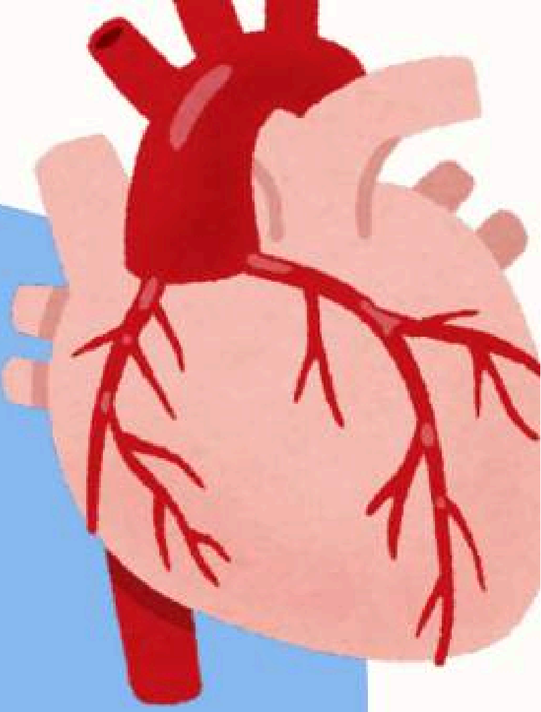


14) INDIQUEZ LA(LES) RÉPONSE(S) EXACTE CONCERNANT LA PHYSIOPATHOLOGIE DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE :

A - OCCLUSION CORONAIRE BRUTALE SECONDAIRE À UN EMBOLE CARDIAQUE
B - STÉNOSE CORONAIRE PROGRESSIVEMENT CROISSANTE D'UNE PLAQUE ATHÉROMATEUSE
C - OCCLUSION CORONAIRE BRUTALE SECONDAIRE À UNE EMBOLIE SUR THROMBOSE VEINEUSE
D - OBSTRUCTION CORONAIRE SURVENANT SUR UNE PLAQUE D'ATHÉROME INSTABLE
E - AUCUNE DE CES RÉPONSES N'EST EXACTE







14) INDIQUEZ LA(LES) RÉPONSE(S) EXACTE CONCERNANT LA PHYSIOPATHOLOGIE DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE :

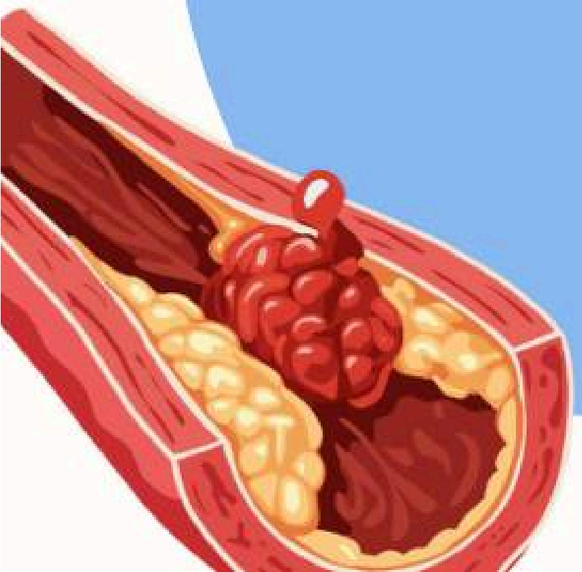
A - OCCLUSION CORONAIRE BRUTALE SECONDAIRE À UN EMBOLE CARDIAQUE

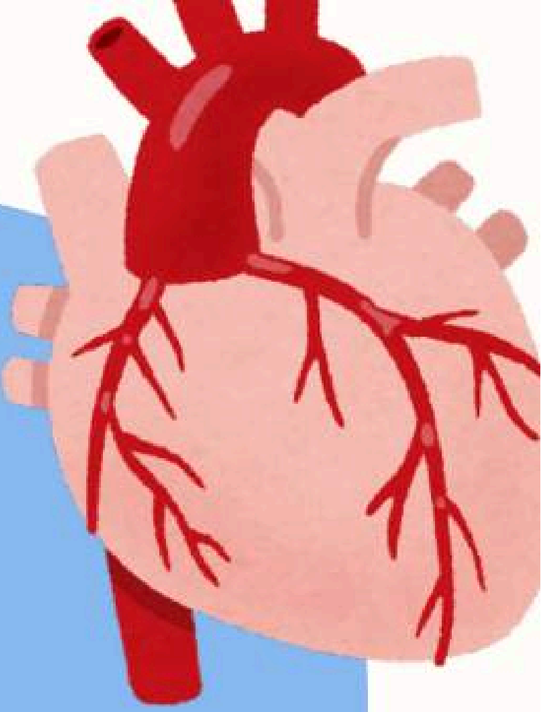
B - STÉNOSE CORONAIRE PROGRESSIVEMENT CROISSANTE D'UNE PLAQUE ATHÉROMATEUSE

C - OCCLUSION CORONAIRE BRUTALE SECONDAIRE À UNE EMBOLIE SUR THROMBOSE VEINEUSE ⇒ FAUX CAR VA DANS LES POUMONS (CF SCHÉMA CIRCULATION SANGUINE)

D - OBSTRUCTION CORONAIRE SURVENANT SUR UNE PLAQUE D'ATHÉROME INSTABLE

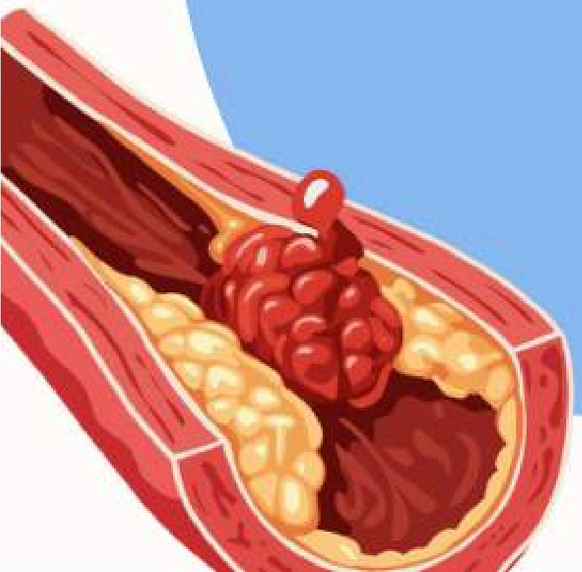
E - AUCUNE DE CES RÉPONSES N'EST EXACTE

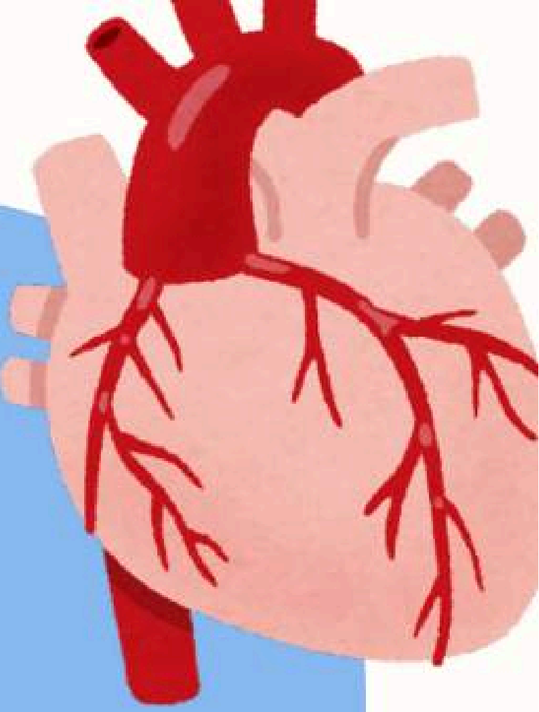




15) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LESQUELLES SONT VRAIES ? LES FACTEURS DE RISQUE DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE SONT :

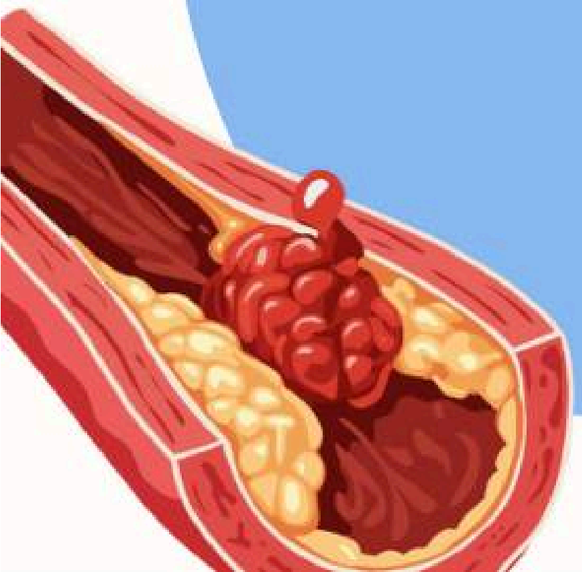
A - OBÉSITÉ
B - TABAC
C - DYSLIPIDÉMIE
D - HYPERACTIVITÉ
E - DIABÈTE

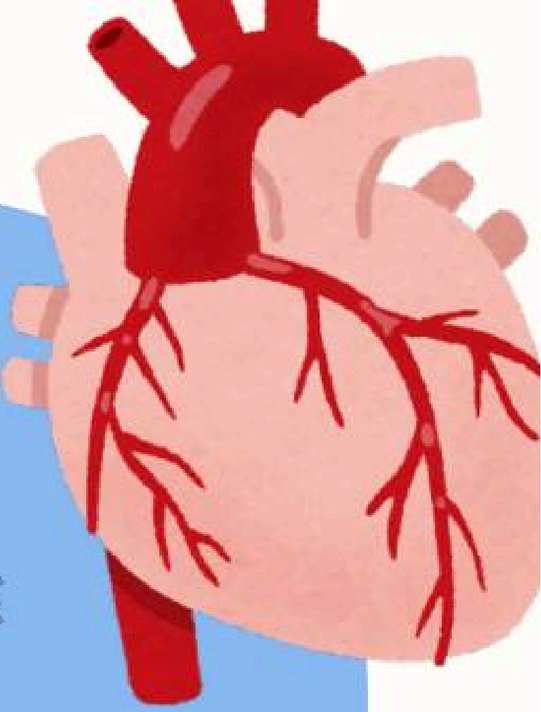




15) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LESQUELLES SONT VRAIES ? LES FACTEURS DE RISQUE DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE SONT :

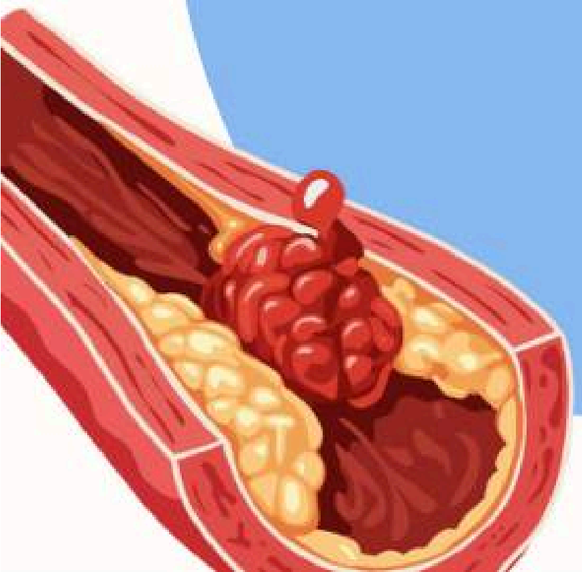
A - OBÉSITÉ
B - TABAC
C - DYSLIPIDÉMIE
D - HYPERACTIVITÉ
E - DIABÈTE

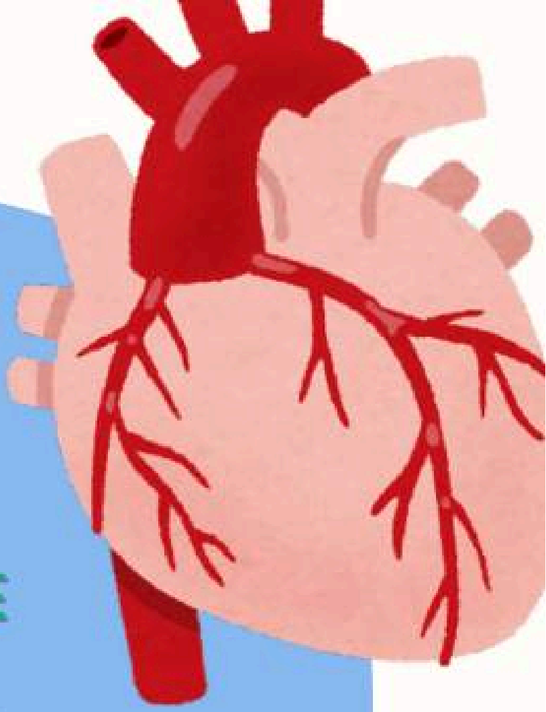




16) QUELLES SONT LES RÉPONSES EXACTES CONCERNANT L'INFARCTUS DU MYOCARDE À LA PHASE AIGUË :

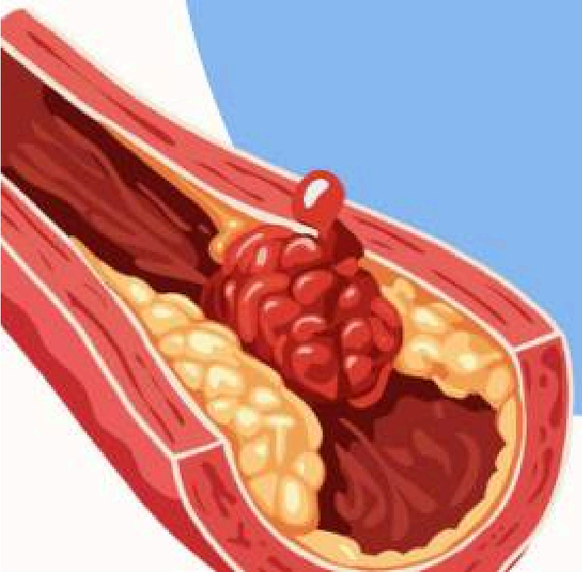
A - IL SE DÉCLARE PAR UNE DOULEUR THORACIQUE CONSTRICTIVE
B - LA DOULEUR EST TRINITRO-RÉSISTANTE
C - IL FAUT ATTENDRE LE DOSAGE DE D-DIMÈRES POUR FAIRE LE DIAGNOSTIC
D - IL NE NÉCESSITE PAS UNE SURVEILLANCE SCOPIQUE
E - IL PEUT SE COMPLIQUER DE TROUBLE DU RYTHME VENTRICULAIRE

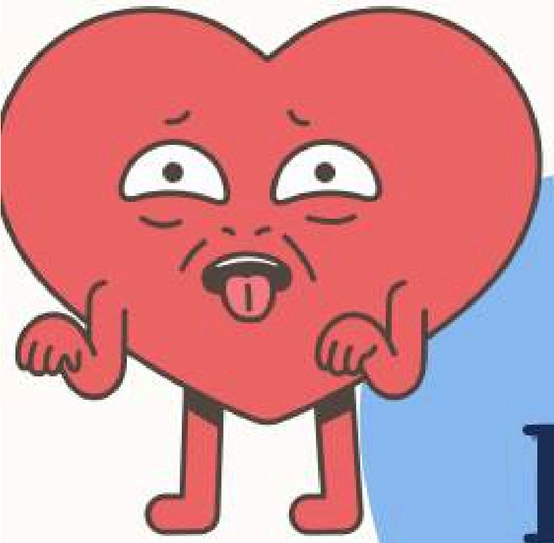




16) QUELLES SONT LES RÉPONSES EXACTES CONCERNANT L'INFARCTUS DU MYOCARDE À LA PHASE AIGUË :

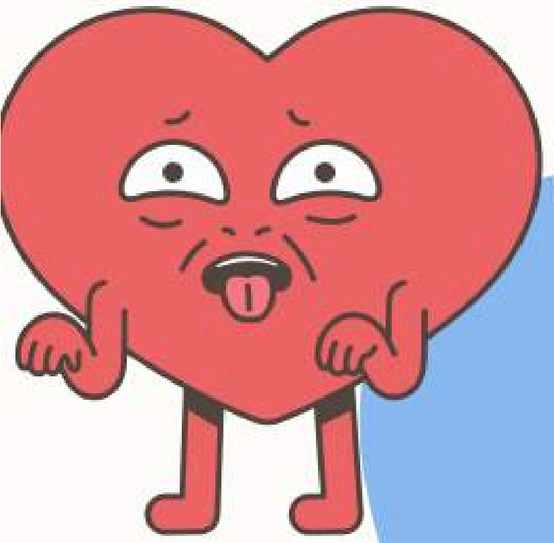
A - IL SE DÉCLARE PAR UNE DOULEUR THORACIQUE CONSTRICTIVE
B - LA DOULEUR EST TRINITRO-RÉSISTANTE
C - IL FAUT ATTENDRE LE DOSAGE DE D-DIMÈRES POUR FAIRE LE DIAGNOSTIC
D - IL NE NÉCESSITE PAS UNE SURVEILLANCE SCOPIQUE
E - IL PEUT SE COMPLIQUER DE TROUBLE DU RYTHME VENTRICULAIRE





INSUFFISANCE CARDIAQUE ET OEDÈME AIGU DU POUMON (OAP)

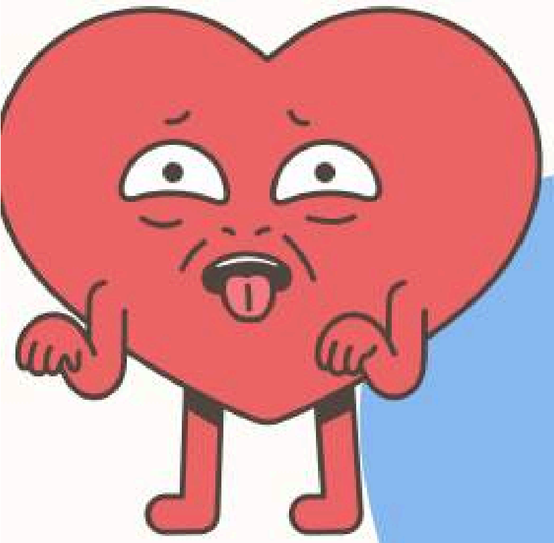




17) L'OAP CARDIOGÉNIQUE RÉSULTE :

A - D'UNE DÉFAILLANCE CARDIAQUE DROITE
B - D'UNE DÉFAILLANCE CARDIAQUE GAUCHE



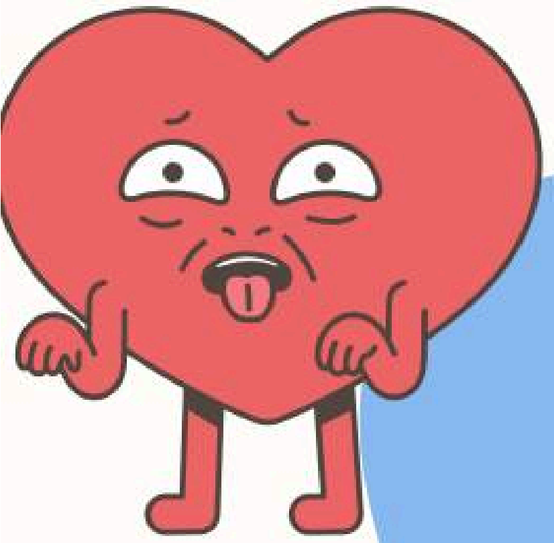


17) L'OAP CARDIOGÉNIQUE RÉSULTE :

A - D'UNE DÉFAILLANCE CARDIAQUE DROITE

B - D'UNE DÉFAILLANCE CARDIAQUE GAUCHE

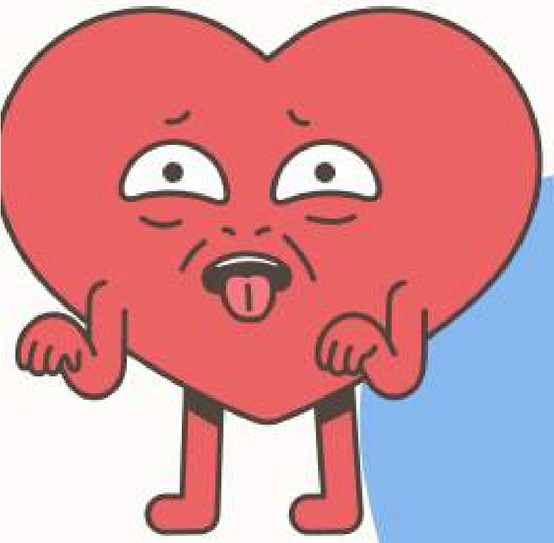




18) QUELLE EST LA DÉFINITION DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (ICC) ?

A. TROUBLE DU RYTHME CARDIAQUE ENTRAÎNANT UNE HYPOPERFUSION CÉRÉBRALE
B. ANOMALIE DE LA STRUCTURE OU FONCTION CARDIAQUE EMPÊCHANT LE CŒUR DE DÉLIVRER LES BESOINS EN OXYGÈNE DE L'ORGANISME
C. DIMINUTION DU DÉBIT SANGUIN HÉPATIQUE
D. ÉTAT DE CHOC SECONDAIRE À UNE INFECTION





18) QUELLE EST LA DÉFINITION DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE (ICC) ?

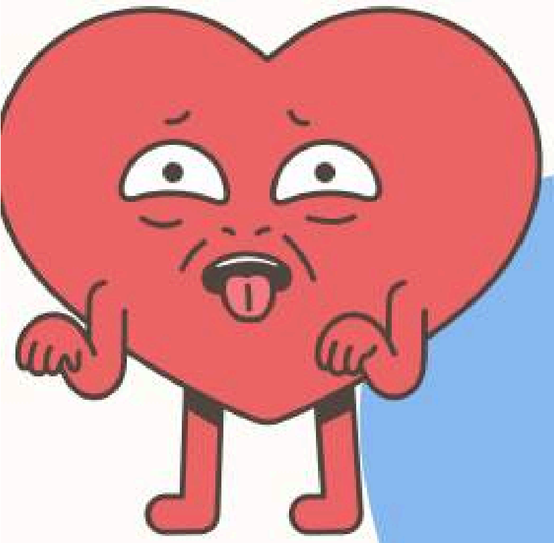
A. TROUBLE DU RYTHME CARDIAQUE ENTRAÎNANT UNE HYPOPERFUSION CÉRÉBRALE

B. ANOMALIE DE LA STRUCTURE OU FONCTION CARDIAQUE EMPÊCHANT LE CŒUR DE DÉLIVRER LES BESOINS EN OXYGÈNE DE L'ORGANISME

C. DIMINUTION DU DÉBIT SANGUIN HÉPATIQUE

D. ÉTAT DE CHOC SECONDAIRE À UNE INFECTION

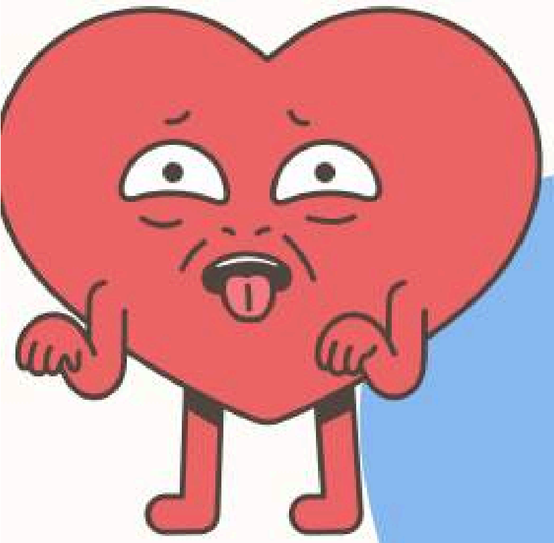




19) QUELLE CLASSE NYHA CORRESPOND À UNE DYSPNÉE POUR DES EFFORTS IMPORTANTS DE LA VIE COURANTE (EX. MONTER DEUX ÉTAGES) ?

A. CLASSE I
B. CLASSE II
C. CLASSE III
D. CLASSE IV

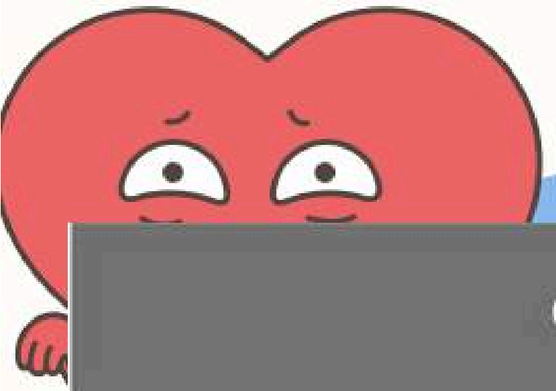




19) QUELLE CLASSE NYHA CORRESPOND À UNE DYSPNÉE POUR DES EFFORTS IMPORTANTS DE LA VIE COURANTE (EX. MONTER DEUX ÉTAGES) ?

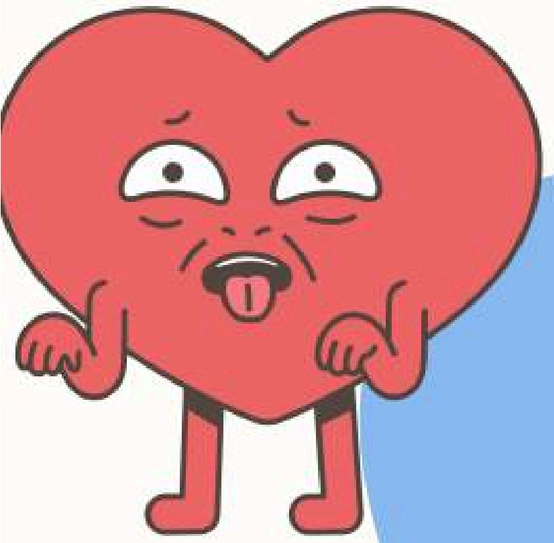
A. CLASSE I
B. CLASSE II
C. CLASSE III
D. CLASSE IV





CLASSES FONCTIONNELLES DE LA NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA)	
CLASSE 1	• Aucune limitation d'activité. Les patients ne souffrent d'aucun symptôme au cours des activités ordinaires. Des efforts physiques inhabituels peuvent cependant être responsables d'un essoufflement.
CLASSE 2	• Limitation d'activité légère à modérée. Pas de limitation au repos mais apparaissant pour des activités normales pour l'âge.
CLASSE 3	• Limitation d'activité marquée. Pas de limitation au repos mais apparaissant pour des activités inférieures à la normale pour l'âge.
CLASSE 4	• Limitation au moindre effort et/ou au repos.

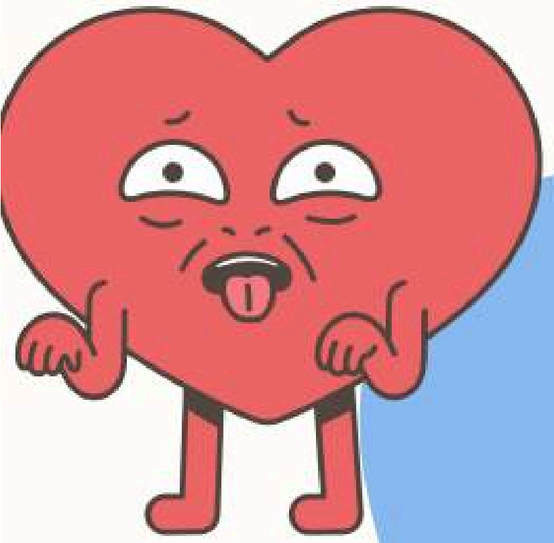




20) QUELLE ATTITUDE EST CONTRE-INDIQUÉE DANS LA PRISE EN CHARGE D'UN OAP ?

A. INSTALLATION DEMI-ASSISE
B. PERFUSION DE NACL $0,9$ %
C. ADMINISTRATION DE FUROSÉMIDE IV
D. SURVEILLANCE DE LA DIURÈSE





20) QUELLE ATTITUDE EST CONTRE-INDIQUÉE DANS LA PRISE EN CHARGE D'UN OAP ?

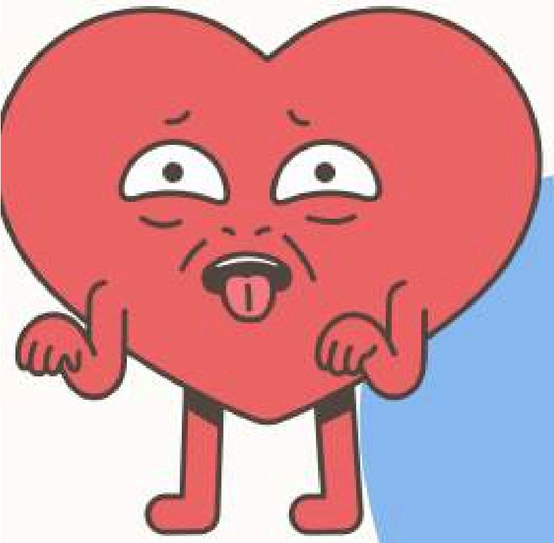
A. INSTALLATION DEMI-ASSISE

B. PERFUSION DE NACL 0,9 %

C. ADMINISTRATION DE FUROSÉMIDE IV

D. SURVEILLANCE DE LA DIURÈSE

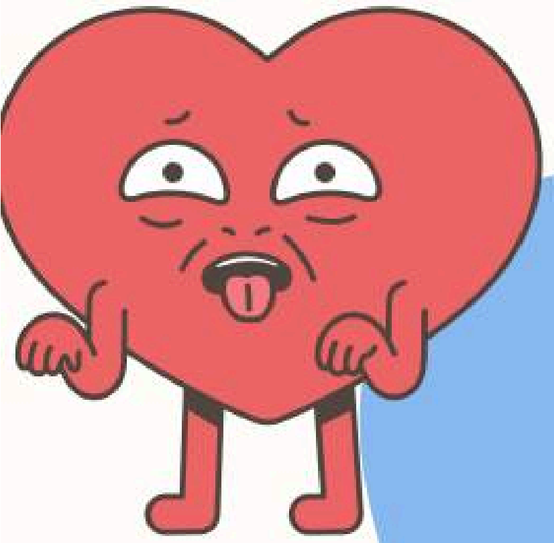




21) LA VENTILATION NON INVASIVE (VNI) EST INDIQUÉE LORSQUE :

A. SPO_2 < 90 % APRÈS TRAITEMENT INITIAL
B. LE PATIENT PRÉSENTE UNE HYPERTHERMIE
C. LE PATIENT EST CONSCIENT ET STABLE
D. LE NT-PROBNP EST BAS

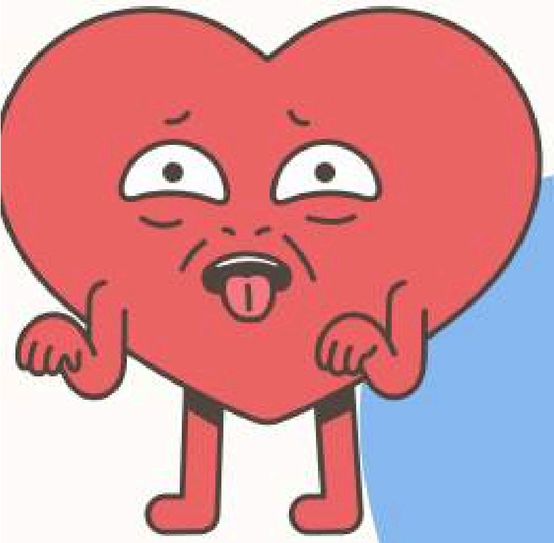




21) LA VENTILATION NON INVASIVE (VNI) EST INDIQUÉE LORSQUE :

A. SPO_2 < 90 % APRÈS TRAITEMENT INITIAL
B. LE PATIENT PRÉSENTE UNE HYPERTHERMIE
C. LE PATIENT EST CONSCIENT ET STABLE
D. LE NT-PROBNP EST BAS

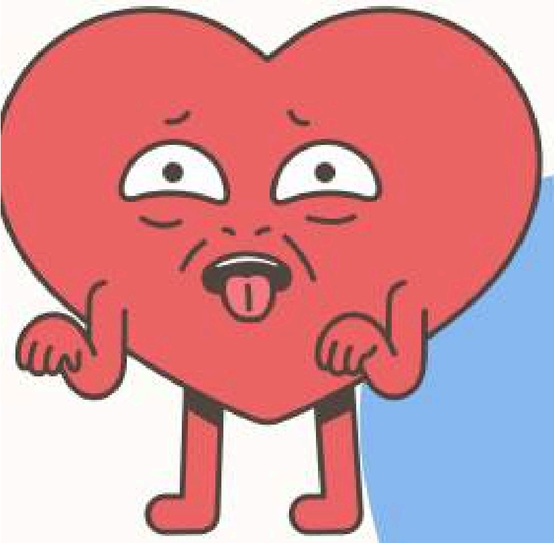




22) LE MÉCANISME ESSENTIEL DE L'OAP CARDIOGÉNIQUE EST :

A. UNE OBSTRUCTION BRONCHIQUE
B. UNE HYPERPERMÉABILITÉ CAPILLAIRE PULMONAIRE
C. UNE ÉLÉVATION DE LA PRESSION CAPILLAIRE PULMONAIRE DUE À LA DÉFAILLANCE DU VG
D. UNE INFLAMMATION PULMONAIRE AIGUË

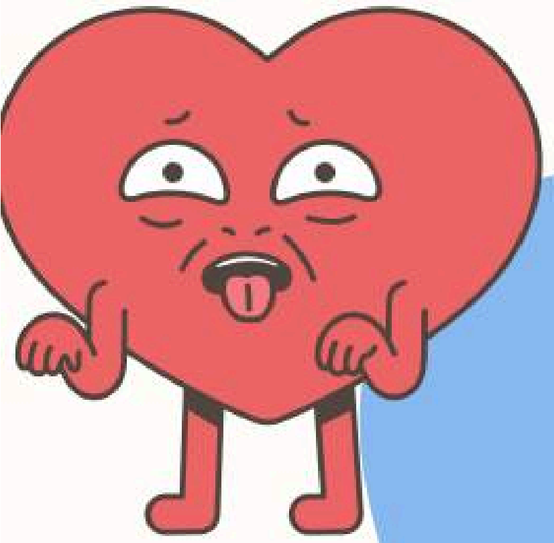




22) LE MÉCANISME ESSENTIEL DE L'OAP CARDIOGÉNIQUE EST :

A. UNE OBSTRUCTION BRONCHIQUE
B. UNE HYPERPERMÉABILITÉ CAPILLAIRE PULMONAIRE
C. UNE ÉLÉVATION DE LA PRESSION CAPILLAIRE PULMONAIRE DUE À LA DÉFAILLANCE DU VG
D. UNE INFLAMMATION PULMONAIRE AIGUË

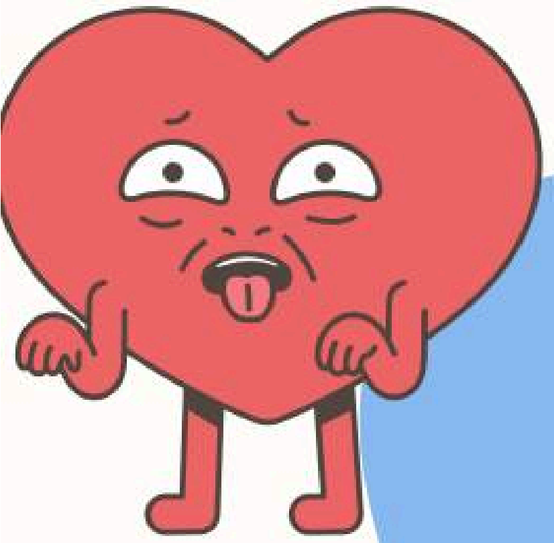




23) LE GAZ DU SANG D'UN OAP TYPIQUE MONTRE SOUVENT :

A. HYPOXIE ET HYPOCAPNIE INITIALE
B. HYPEROXIE
C. ALCALOSE MÉTABOLIQUE
D. HYPERCAPNIE ISOLÉE

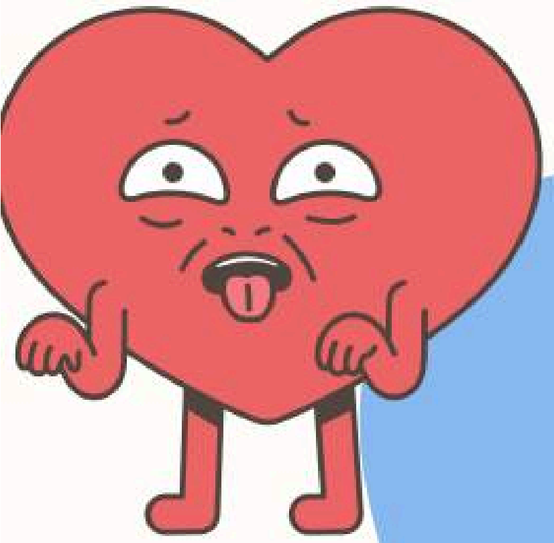


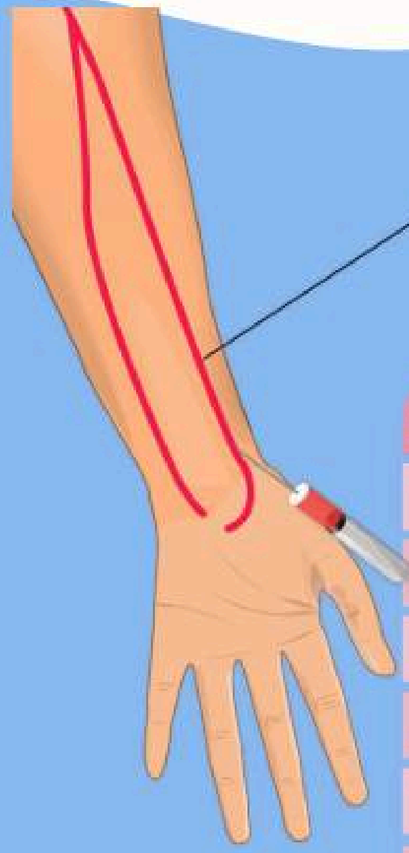


23) LE GAZ DU SANG D'UN OAP TYPIQUE MONTRE SOUVENT :

A. HYPOXIE ET HYPOCAPNIE INITIALE
B. HYPEROXIE
C. ALCALOSE MÉTABOLIQUE
D. HYPERCAPNIE ISOLÉE

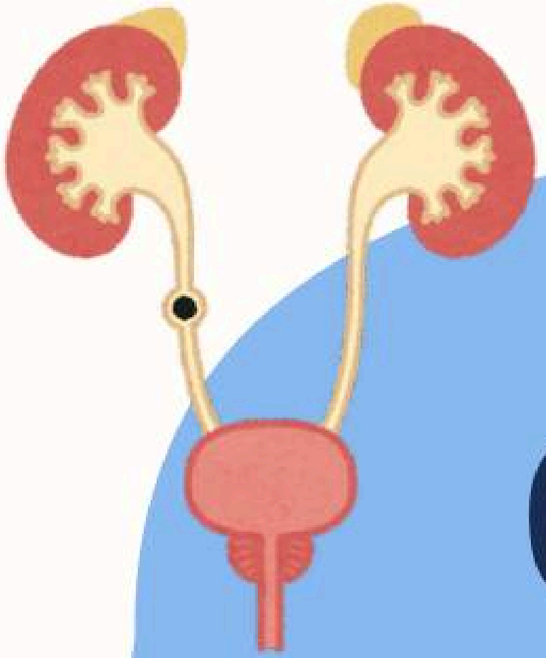






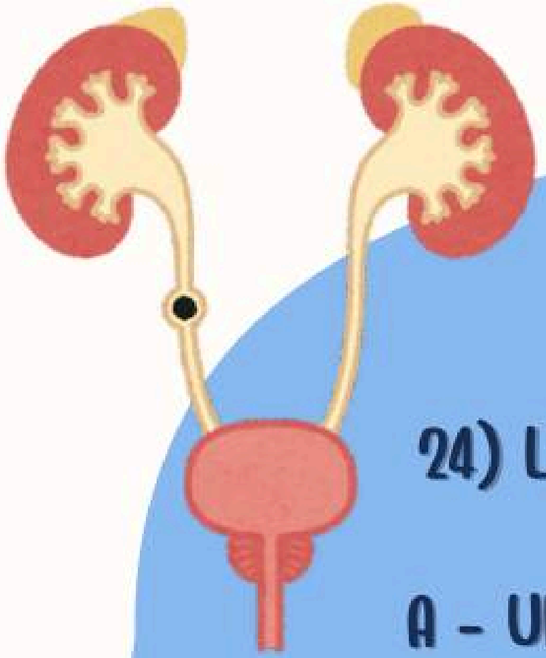
ABG	Normal Range
pH	7.35 - 7.45
$PaCO_2$	35-45 mmHg
PaO_2	80-100 mmHg
HCO_3	21-27 mEq/L
O_2Sat	95-100%
Base Excess	± 2 mEq/L





OBSTRUCTION URO-NÉPHROLOGIQUE

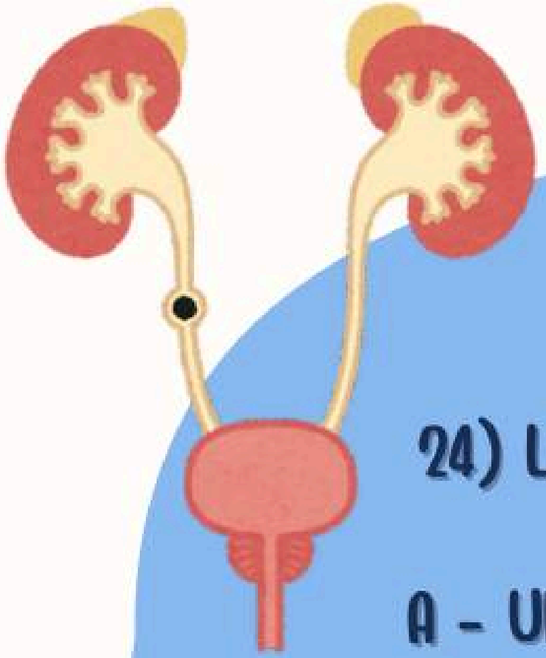




24) LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE AIGUË PEUT-ÊTRE FAVORISÉE PAR :

A - UN SURPLUS D'HYDRATATION QUI AUGMENTE LA TENSION RÉNALE
B - UN EFFORT PHYSIQUE PROLONGÉE DANS UNE AMBIANCE SURCHAUFFÉE
C - UN MANQUE DE POTASSIUM
D - UN EXCÈS DE PROTÉINES ANIMALES





24) LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE AIGUË PEUT-ÊTRE FAVORISÉE PAR :

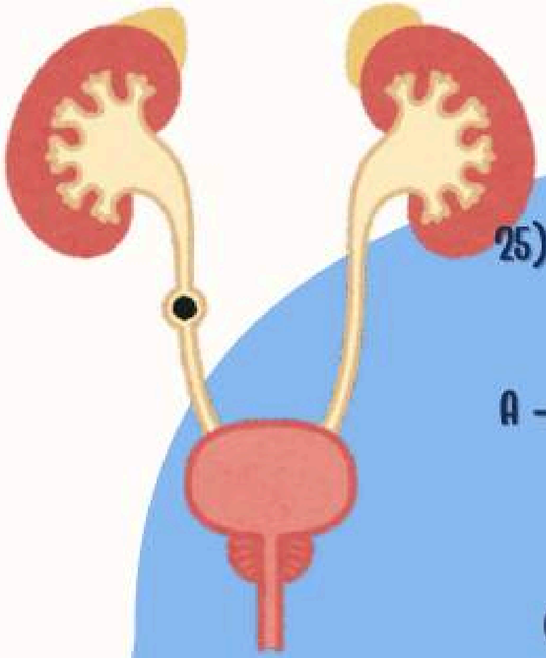
A - UN SURPLUS D'HYDRATATION QUI AUGMENTE LA TENSION RÉNALE

B - UN EFFORT PHYSIQUE PROLONGÉE DANS UNE AMBIANCE SURCHAUFFÉE

C - UN MANQUE DE POTASSIUM

D - UN EXCÈS DE PROTÉINES ANIMALES





25) QUELLES AFFIRMATIONS SUIVANTES CONCERNANT LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE SONT VRAIES :

A - LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE SE TRADUIT SYSTÉMATIQUEMENT PAR UNE DOULEUR VIOLENTE POUR LAQUELLE LE PATIENT NE TROUVE PAS DE POSITION ANTALGIQUE

B - LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE EST LA MISE SOUS TENSION BRUTALE DU BASSINET, DE L'URETÈRE ET DE LA VESSIE

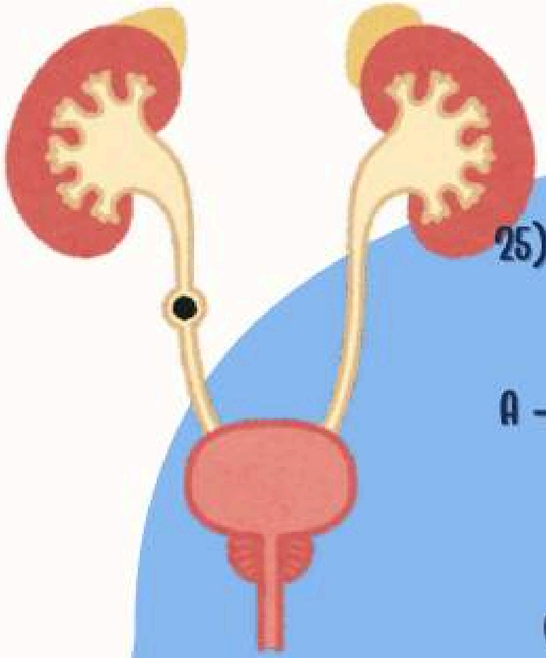
C - LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE SE TRADUIT PAR UNE DOULEUR À L'HYPOCHONDRE DROIT IRRADIANT AUX ORGANES GÉNITAUX EXTERNES

D - LA PYÉLONÉPHRITE EST UNE COMPLICATION POSSIBLE DE LA CRISE DE LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE

E - LA BANDELETTE URINAIRE RÉALISÉ PERMET DE POSER UN DIAGNOSTIC D'INFECTION URINAIRE

F - IL EST CONSEILLÉ DE BOIRE DE MANIÈRE IMPORTANTE PENDANT LA CRISE POUR FAVORISER L'ÉLIMINATION DU CALCUL





25) QUELLES AFFIRMATIONS SUIVANTES CONCERNANT LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE SONT VRAIES :

A - LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE SE TRADUIT SYSTÉMATIQUEMENT PAR UNE DOULEUR VIOLENTE POUR LAQUELLE LE PATIENT NE TROUVE PAS DE POSITION ANTALGIQUE

B - LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE EST LA MISE SOUS TENSION BRUTALE DU BASSINET, DE L'URETÈRE ET DE LA VESSIE

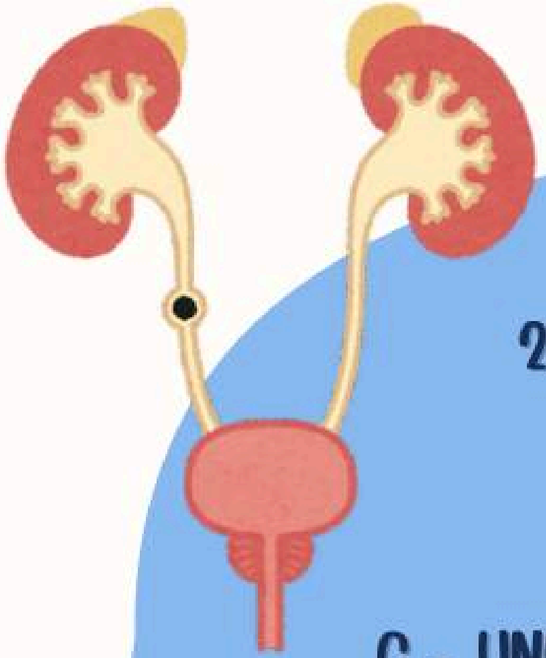
C - LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE SE TRADUIT PAR UNE DOULEUR À L'HYPOCHONDRE DROIT IRRADIANT AUX ORGANES GÉNITAUX EXTERNES

D - LA PYÉLONÉPHRITE EST UNE COMPLICATION POSSIBLE DE LA CRISE DE LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE

E - LA BANDELETTE URINAIRE RÉALISÉ PERMET DE POSER UN DIAGNOSTIC D'INFECTION URINAIRE

F - IL EST CONSEILLÉ DE BOIRE DE MANIÈRE IMPORTANTE PENDANT LA CRISE POUR FAVORISER L'ÉLIMINATION DU CALCUL

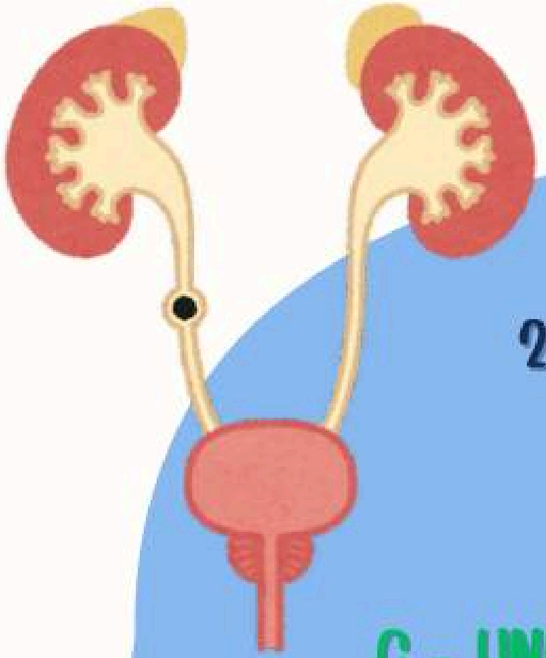




26) LA CRISE DE COLIQUE NÉPHRÉTIQUE SE TRADUIT PAR :

A - UNE OBSTRUCTION DE L'URÈTRE PAR UN CALCUL
B - UNE OBSTRUCTION DE L'URETÈRE PAR UN CALCUL
C - UNE ÉVOLUTION PAR POUSSÉE PAROXYSTIQUE AVEC DES PÉRIODES D'ACCALMIE
D - UNE ÉVOLUTION PROGRESSIVE DE LA DOULEUR
E - UN ARRÊT SPONTANÉ APRÈS EXPULSION DU CALCUL





26) LA CRISE DE COLIQUE NÉPHRÉTIQUE SE TRADUIT PAR :

A - UNE OBSTRUCTION DE L'URÈTRE PAR UN CALCUL

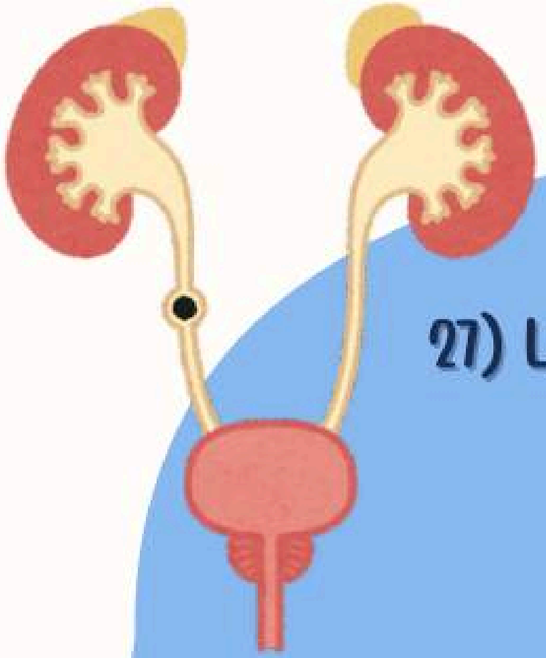
B - UNE OBSTRUCTION DE L'URETÈRE PAR UN CALCUL

C - UNE ÉVOLUTION PAR POUSSÉE PAROXYSTIQUE AVEC DES PÉRIODES D'ACCALMIE

D - UNE ÉVOLUTION PROGRESSIVE DE LA DOULEUR

E - UN ARRÊT SPONTANÉ APRÈS EXPULSION DU CALCUL

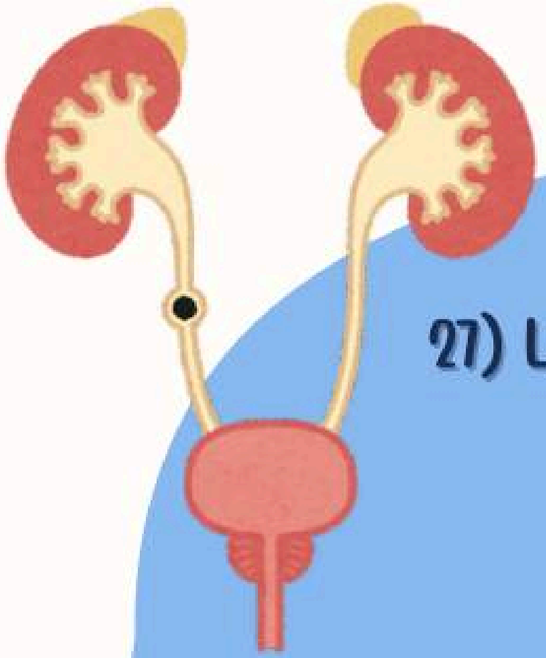




27) LES COMPLICATIONS D'UNE RÉTENTION AIGUE D'URINE SONT :

A - UNE INSUFFISANCE RÉNALE
B - UNE PHLÉBITE
C - UNE PERFORATION VÉSICALE
D - UNE PÉRITONITE
E - UNE INFECTION URINAIRE

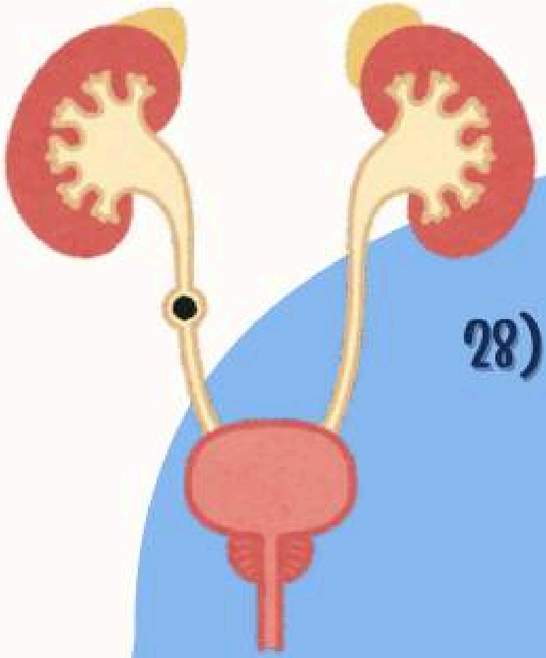




27) LES COMPLICATIONS D'UNE RÉTENTION AIGUE D'URINE SONT :

A - UNE INSUFFISANCE RÉNALE
B - UNE PHLÉBITE
C - UNE PERFORATION VÉSICALE
D - UNE PÉRITONITE
E - UNE INFECTION URINAIRE

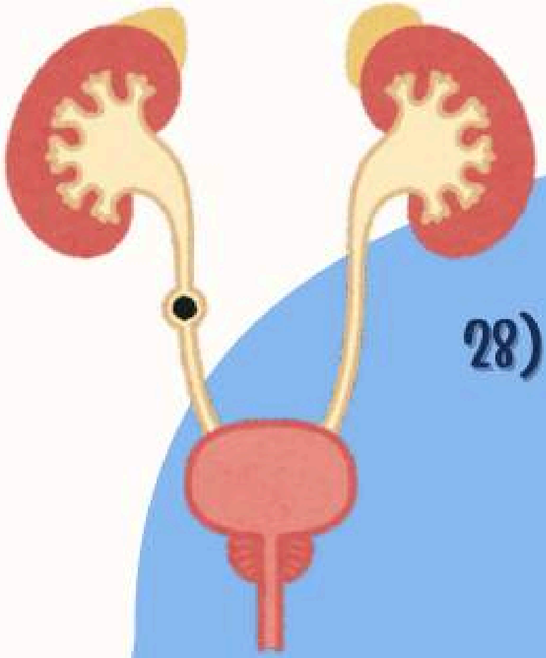




28) LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE NÉCESSITE UNE DÉRIVATION EN URGENCE EN CAS DE :

A - REIN UNIQUE
B - PYÉLONÉPHRITE ASSOCIÉE
C - OBSTRUCTION UNILATÉRALE
D - COLIQUE NÉPHRÉTIQUE RÉSISTANTE AU TRAITEMENT
E - EXPULSION SPONTANÉE DU CALCUL

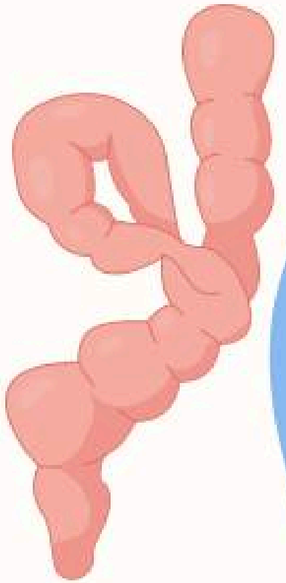


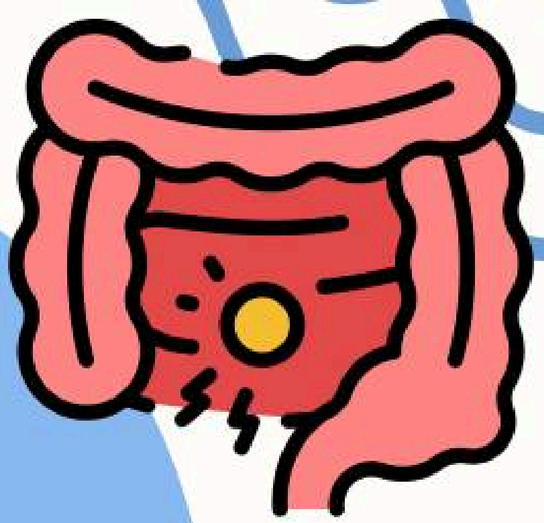


28) LA COLIQUE NÉPHRÉTIQUE NÉCESSITE UNE DÉRIVATION EN URGENCE EN CAS DE :

A - REIN UNIQUE
B - PYÉLONÉPHRITE ASSOCIÉE
C - OBSTRUCTION UNILATÉRALE
D - COLIQUE NÉPHRÉTIQUE RÉSISTANTE AU TRAITEMENT
E - EXPULSION SPONTANÉE DU CALCUL

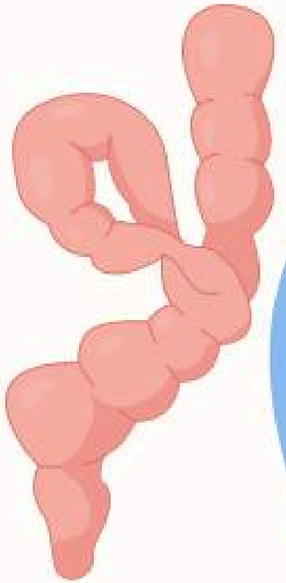


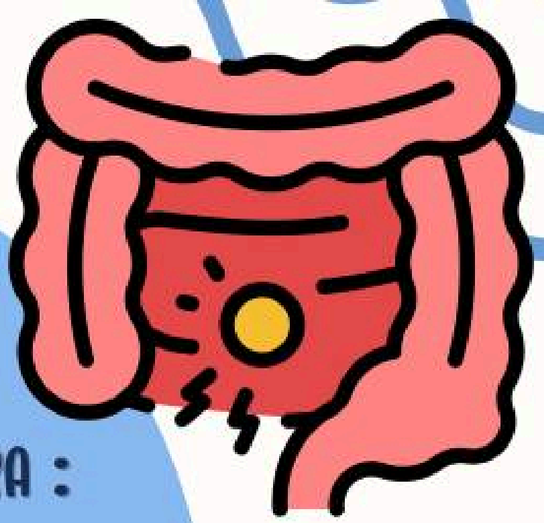




OBSTRUCTION DIGESTIVE



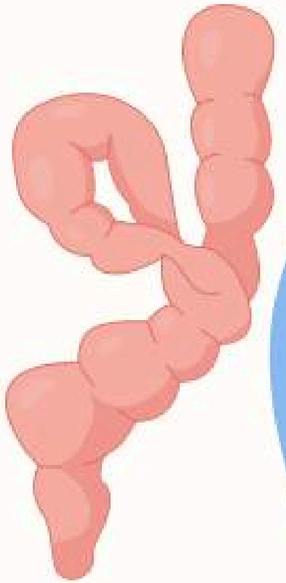


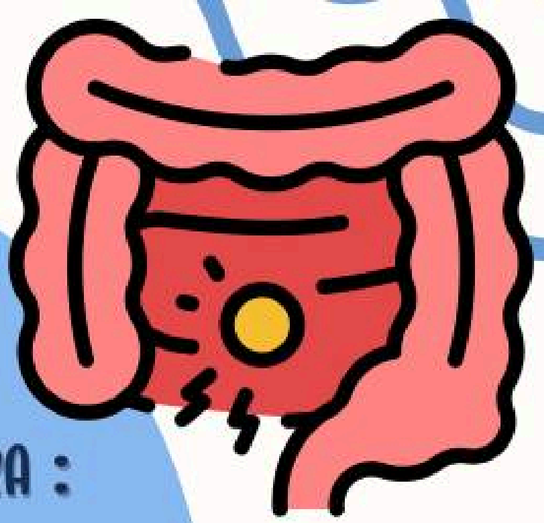


29) LORS D'UNE CHOLÉCYSTITE AIGUË, LE TRAITEMENT SERA :

A - UNE CHOLÉDOCOTOMIE
B - UNE CHOLÉCYSTECTOMIE
C - UNE CHOLÉCYSTOSTOMIE
D - UNE COLECTOMIE
E - UNE COLOSTOMIE



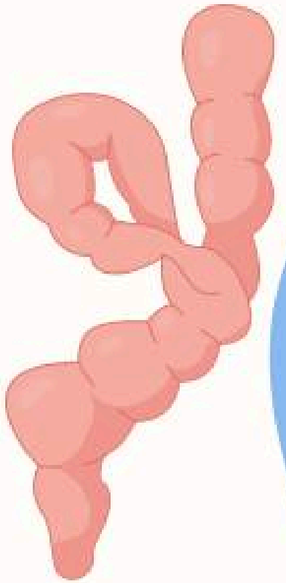


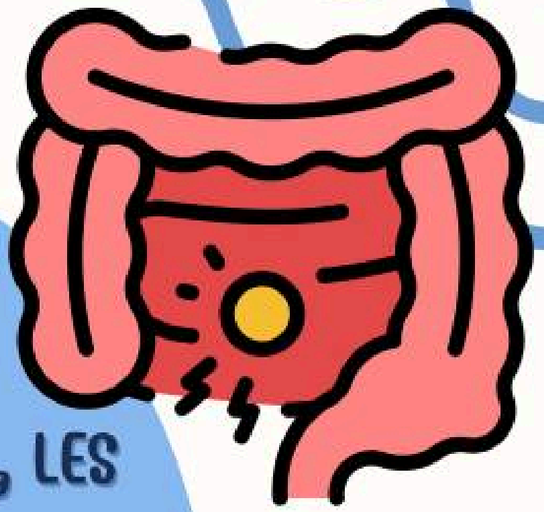


29) LORS D'UNE CHOLÉCYSTITE AIGUË, LE TRAITEMENT SERA :

A - UNE CHOLÉDOCOTOMIE
B - UNE CHOLÉCYSTECTOMIE
C - UNE CHOLÉCYSTOSTOMIE
D - UNE COLECTOMIE
E - UNE COLOSTOMIE



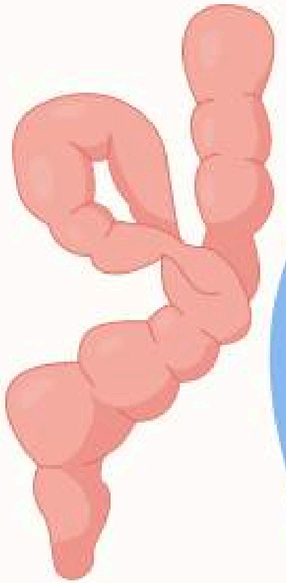


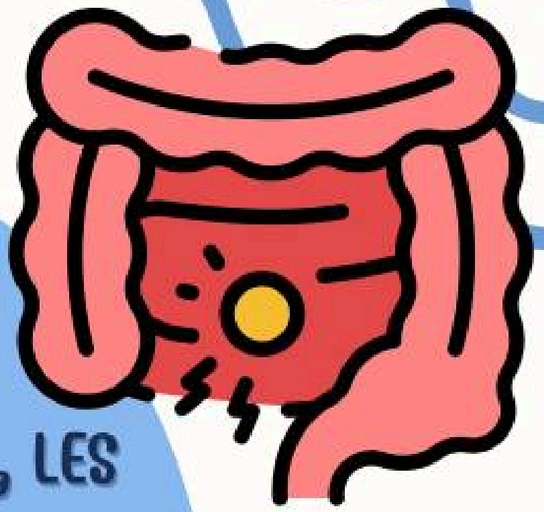


30) POUR UN PATIENT PRÉSENTANT UNE PANCRÉATITE AIGUË, LES SYMPTÔMES RECHERCHÉS SONT :

A - BRADYCARDIE
B - DOULEUR AIGUË
C - HYPOTHERMIE
D - DIARRHÉES
E - OLIGURIE



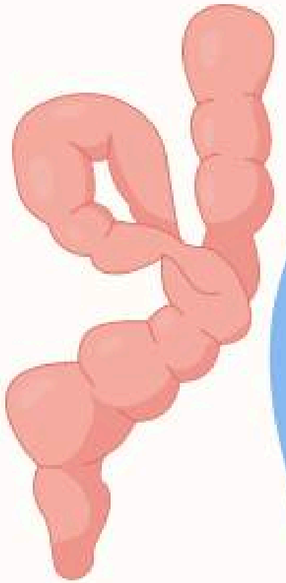


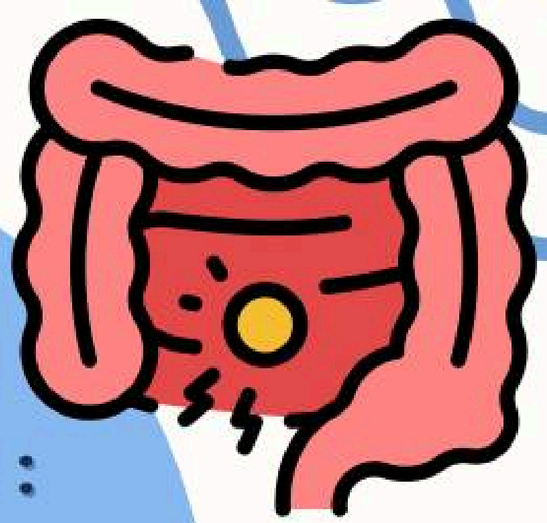


30) POUR UN PATIENT PRÉSENTANT UNE PANCRÉATITE AIGUË, LES SYMPTÔMES RECHERCHÉS SONT :

A - BRADYCARDIE
B - DOULEUR AIGUË
C - HYPOTHERMIE
D - DIARRHÉES
E - OLIGURIE



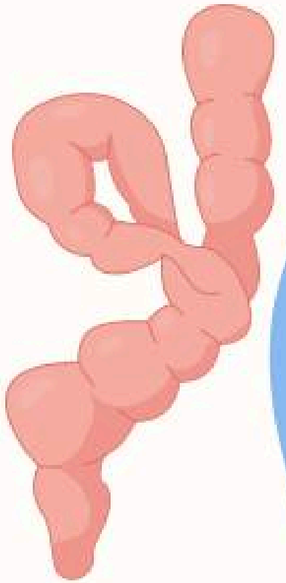


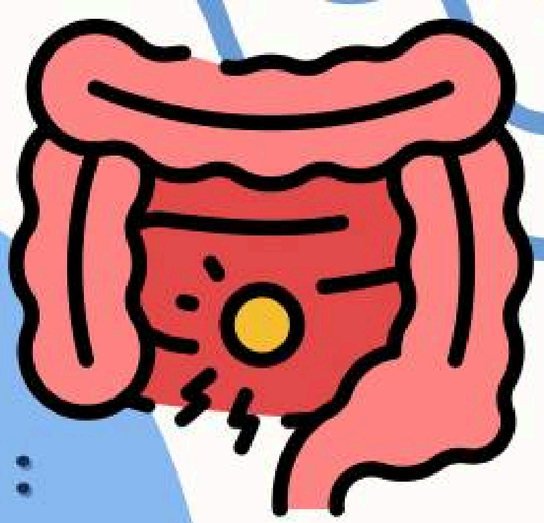


31) LA PANCRÉATITE AIGUË PEUT ÊTRE LA CONSÉQUENCE :

A - DE L'ALCOOLISME
B - D'UN CALCUL VÉSICAL
C - D'UNE HYPOCALCÉMIE
D - D'UN CALCUL VÉSICULAIRE
E - D'UNE HYPERTRIGLYCÉRIDÉMIE



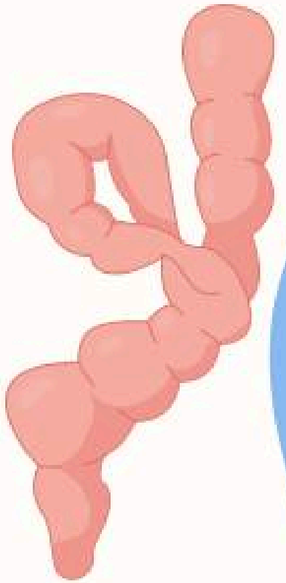


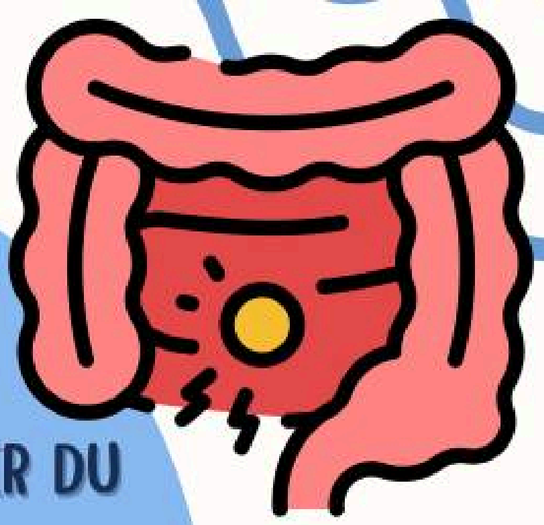


31) LA PANCRÉATITE AIGUË PEUT ÊTRE LA CONSÉQUENCE :

A - DE L'ALCOOLISME
B - D'UN CALCUL VÉSICAL
C - D'UNE HYPOCALCÉMIE
D - D'UN CALCUL VÉSICULAIRE
E - D'UNE HYPERTRIGLYCÉRIDÉMIE



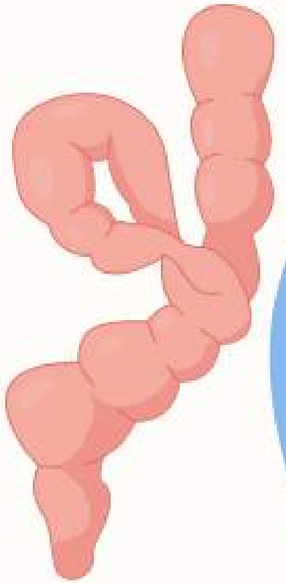


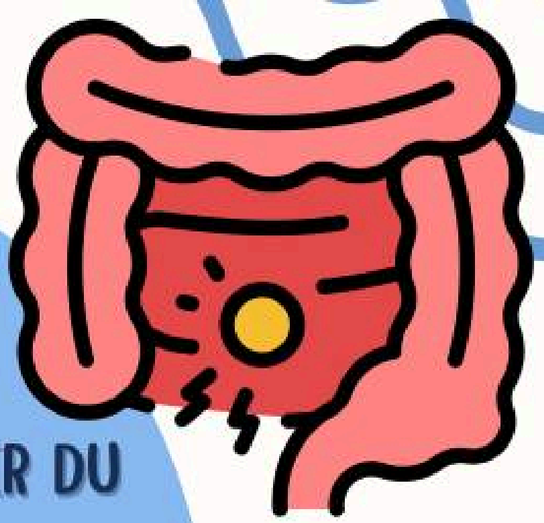


32) LA BILE EST UN PRODUIT FABRIQUÉ PAR LE FOIE À PARTIR DU PRODUIT DE DÉGRADATION DES:

A - LIPIDES
B - PROTIDES
C - GLUCIDES
D - HÉMATIES
E - LEUCOCYTES

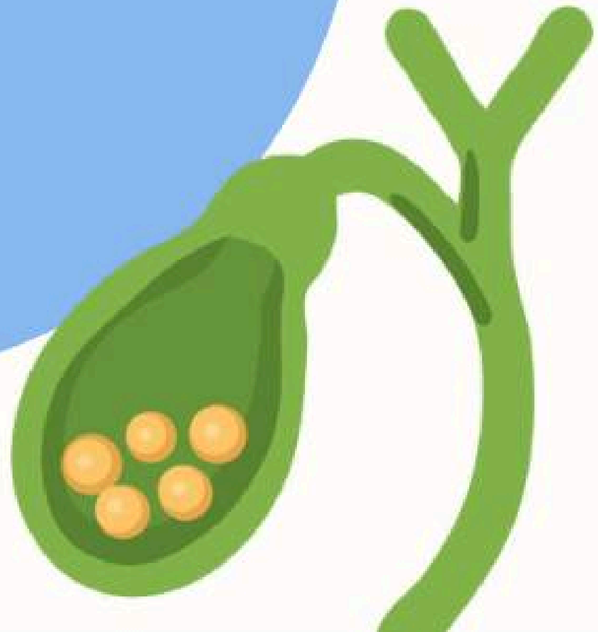


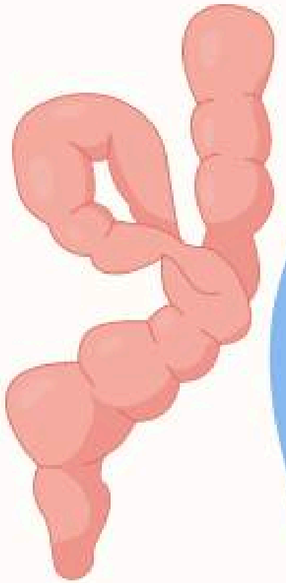


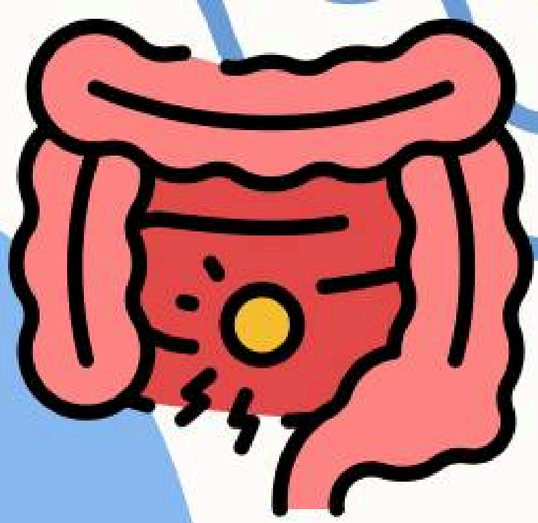


32) LA BILE EST UN PRODUIT FABRIQUÉ PAR LE FOIE À PARTIR DU PRODUIT DE DÉGRADATION DES:

A - LIPIDES
B - PROTIDES
C - GLUCIDES
D - HÉMATIES
E - LEUCOCYTES



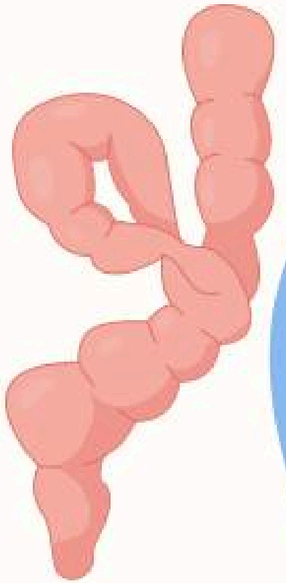


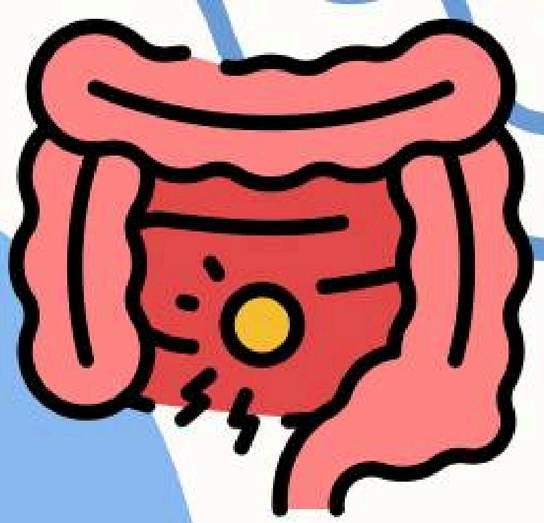


33) LA LITHIASE DU CHOLÉDOQUE PEUT INDUIRE :

A - UNE CIRRHOSE
B - UN ICTÈRE
C - UNE SEPTICÉMIE
D - UNE PANCRÉATITE CHRONIQUE
E - UNE OCCLUSION INTESTINALE



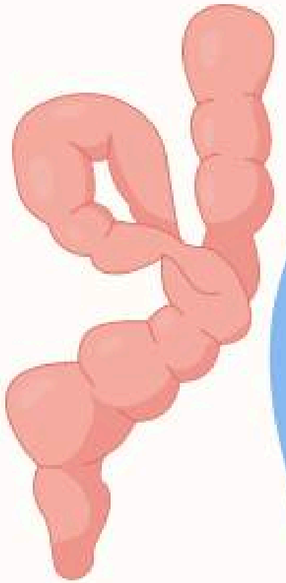


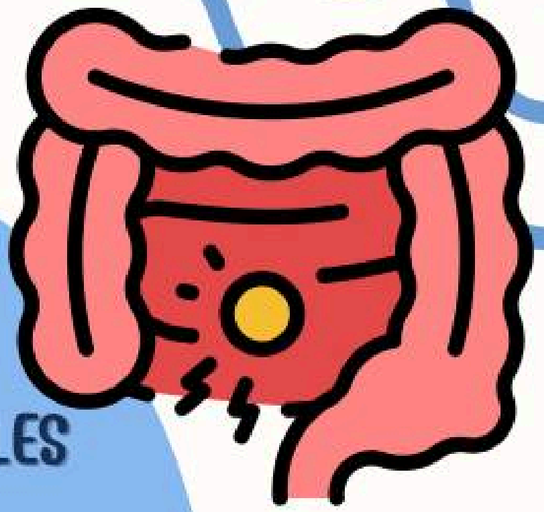


33) LA LITHIASE DU CHOLÉDOQUE PEUT INDUIRE :

A - UNE CIRRHOSE
B - UN ICTÈRE
C - UNE SEPTICÉMIE
D - UNE PANCRÉATITE CHRONIQUE
E - UNE OCCLUSION INTESTINALE



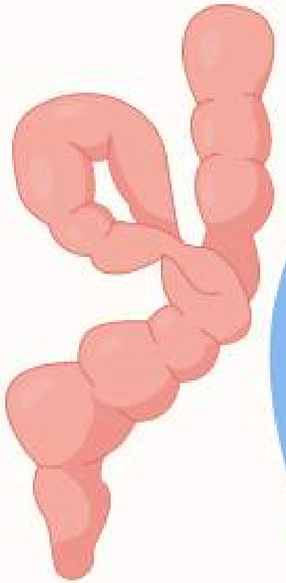


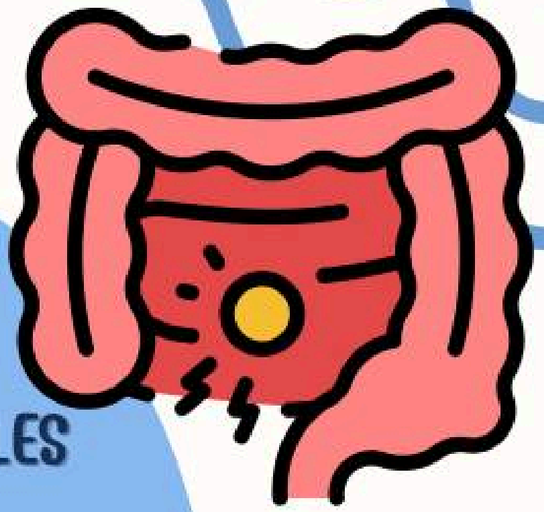


34) QUELLES SONT LES 2 RÉPONSES EXACTES CONCERNANT LES COMPLICATIONS DE LA VOIE BILIAIRE PRINCIPALE :

A - L'ANGIOCHOLITE
B - L'ULCÈRE DUODÉNAL
C - LA PÉRITONITE
D - LE REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN
E - LA PANCRÉATITE AIGUË LITHIASIQUE



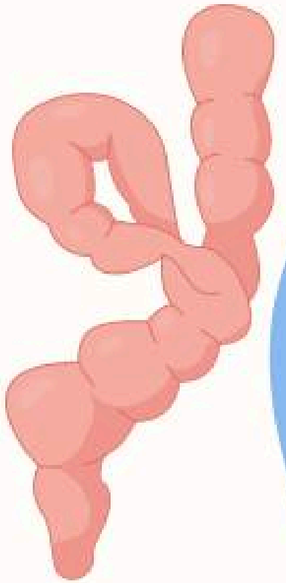


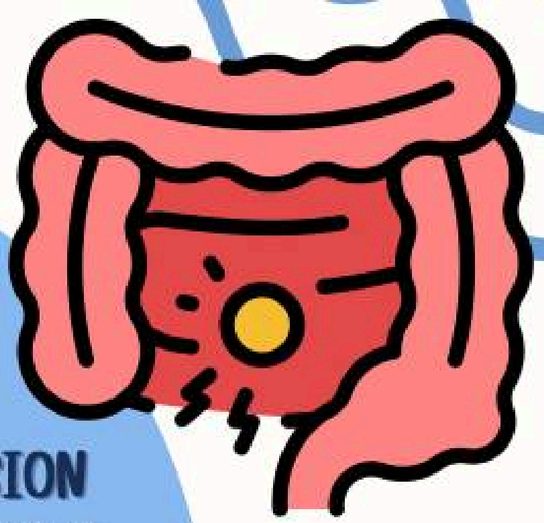


34) QUELLES SONT LES 2 RÉPONSES EXACTES CONCERNANT LES COMPLICATIONS DE LA VOIE BILIAIRE PRINCIPALE :

A - L'ANGIOCHOLITE
B - L'ULCÈRE DUODÉNAL
C - LA PÉRITONITE
D - LE REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN
E - LA PANCRÉATITE AIGUË LITHIASIQUE

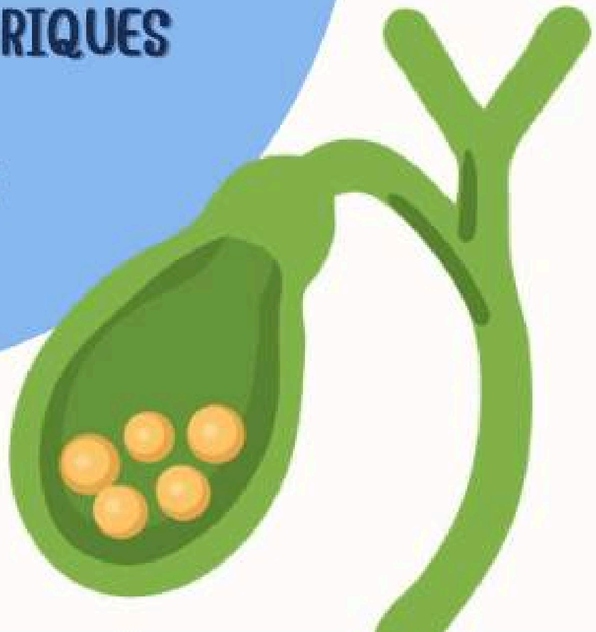


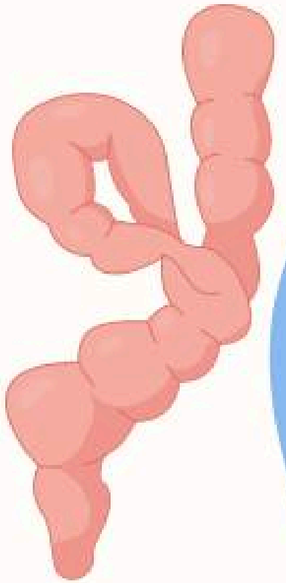


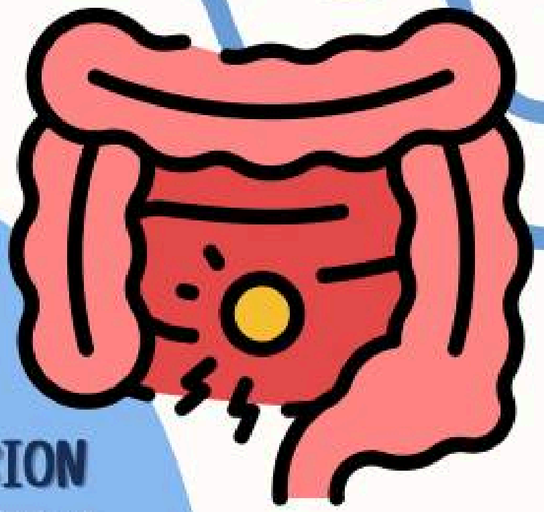


35) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES CONCERNANT L'OCCLUSION INTESTINALE AIGUË PAR STRANGULATION, LESQUELLES SONT VRAIES ?

A - IL EXISTE UNE DÉSHYDRATATION
B - LE PATIENT EST À RISQUE DE CHOC SEPTIQUE
C - À L'IMAGERIE, ON OBSERVE DES NIVEAUX HYDRO-AÉRIQUES
D - IL EXISTE UNE DIARRHÉE AIGUË
E - C'EST UNE URGENCE MÉDICO-CHIRURGICALE

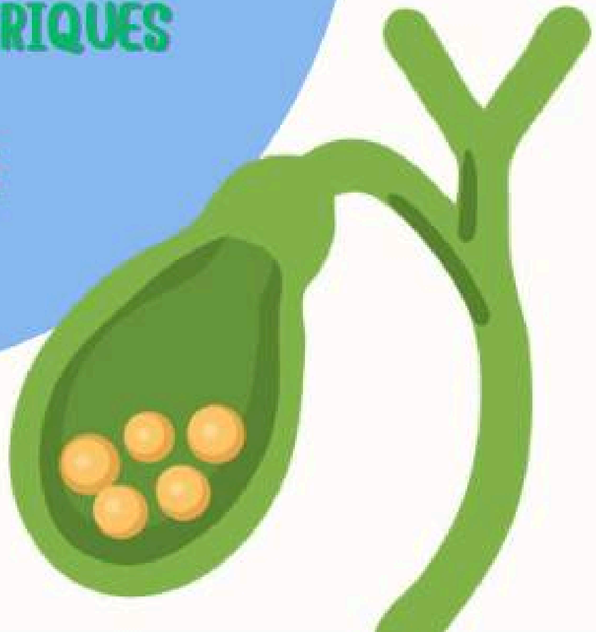


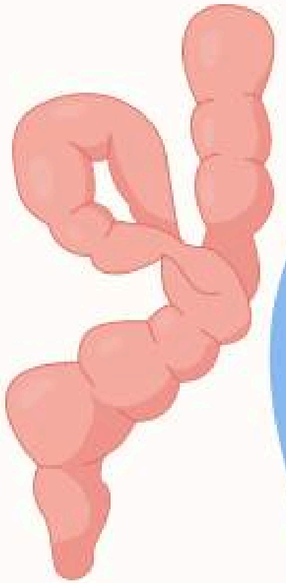


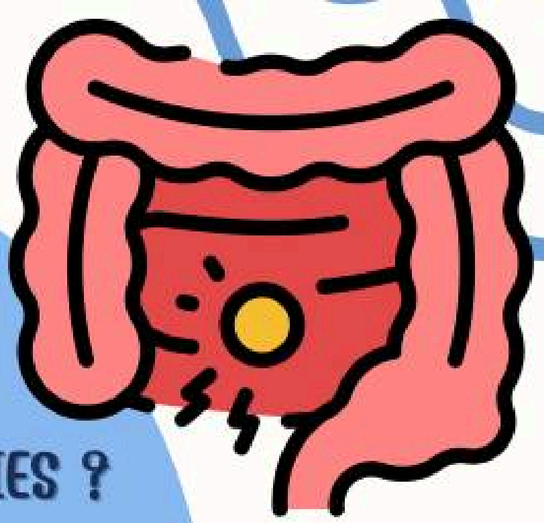


35) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES CONCERNANT L'OCCLUSION INTESTINALE AIGUË PAR STRANGULATION, LESQUELLES SONT VRAIES ?

A - IL EXISTE UNE DÉSHYDRATATION
B - LE PATIENT EST À RISQUE DE CHOC SEPTIQUE
C - À L'IMAGERIE, ON OBSERVE DES NIVEAUX HYDRO-AÉRIQUES
D - IL EXISTE UNE DIARRHÉE AIGUË
E - C'EST UNE URGENCE MÉDICO-CHIRURGICALE



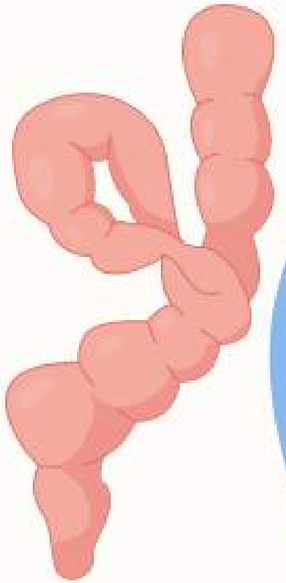


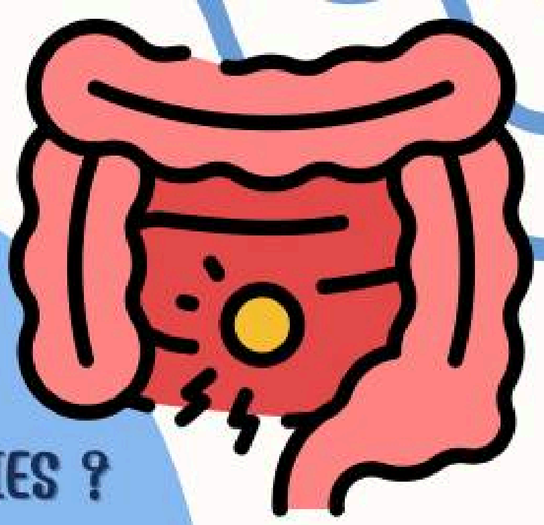


36) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LESQUELLES SONT VRAIES ?
L'OCCLUSION INTESTINALE PEUT ÊTRE DUE À :

A - UN HYPERPÉRISTALTISME
B - UNE TUMEUR DU CÔLON
C - UNE INVAGINATION INTESTINALE
D - UNE BRIDE
E - UNE PÉRITONITE



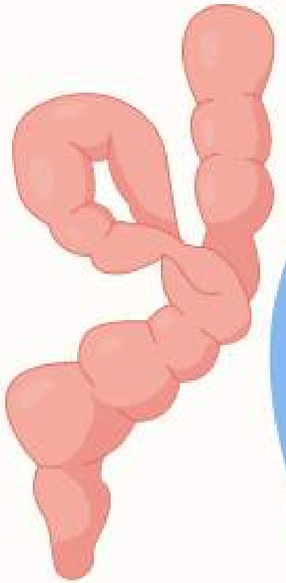


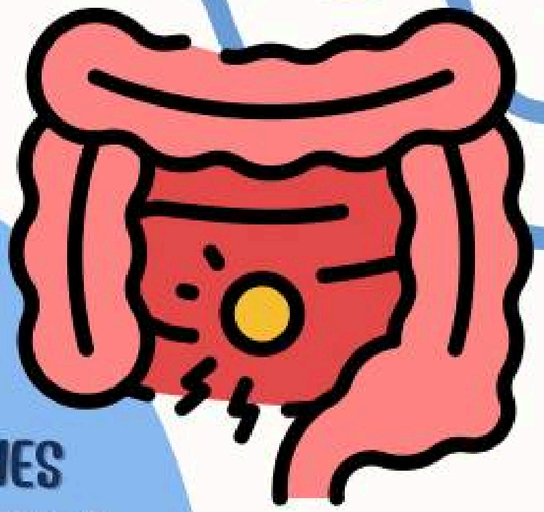


36) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LESQUELLES SONT VRAIES ?
L'OCCLUSION INTESTINALE PEUT ÊTRE DUE À :

A - UN HYPERPÉRISTALTISME
B - UNE TUMEUR DU CÔLON
C - UNE INVAGINATION INTESTINALE
D - UNE BRIDE
E - UNE PÉRITONITE

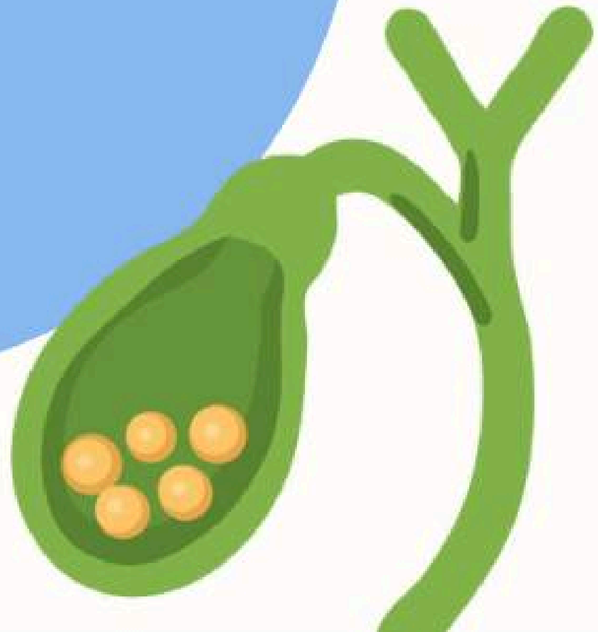


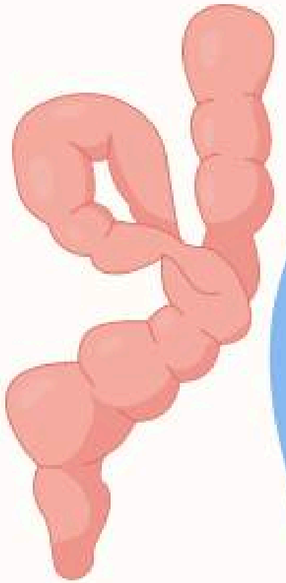


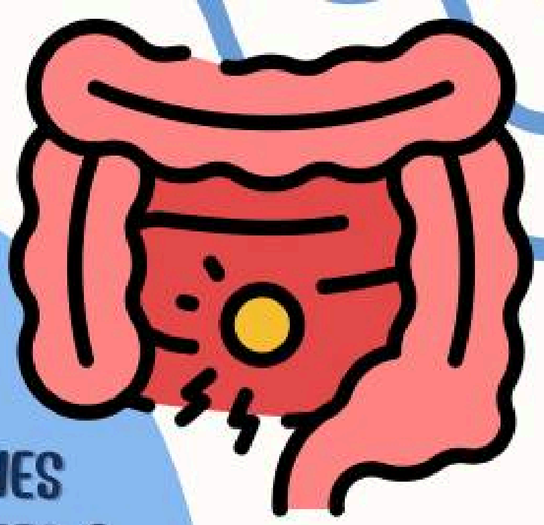


37) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES CONCERNANT LES SIGNES CLINIQUES DE L'OCCLUSION INTESTINALE, LESQUELLES SONT VRAIES ?

A - DOULEURS ABDOMINALES
B - VOMISSEMENTS
C - ICTÈRE
D - DIARRHÉE
E - MÉTÉORISME ABDOMINAL



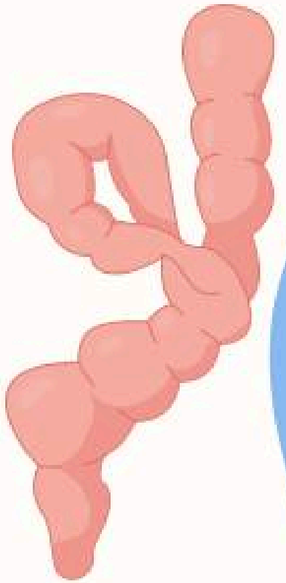


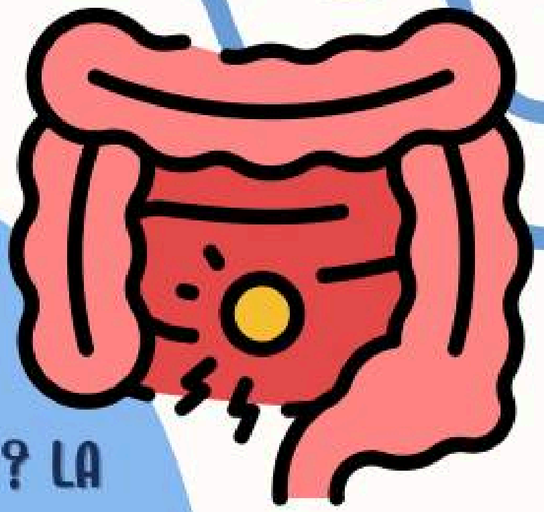


37) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES CONCERNANT LES SIGNES CLINIQUES DE L'OCCLUSION INTESTINALE, LESQUELLES SONT VRAIES ?

A - DOULEURS ABDOMINALES
B - VOMISSEMENTS
C - ICTÈRE
D - DIARRHÉE
E - MÉTÉORISME ABDOMINAL

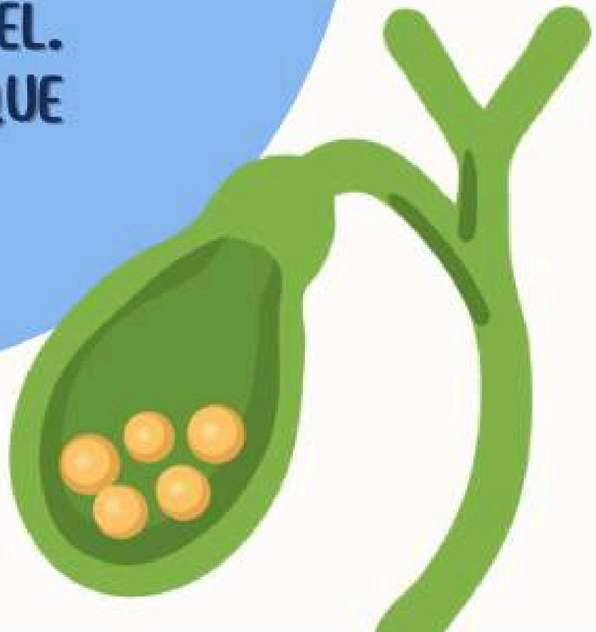


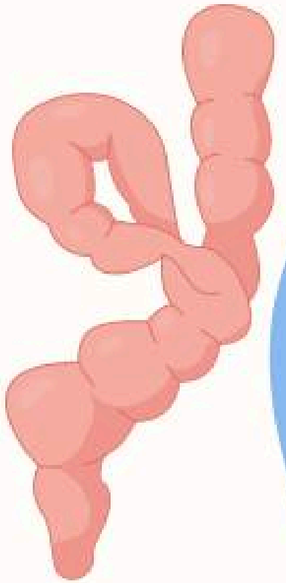


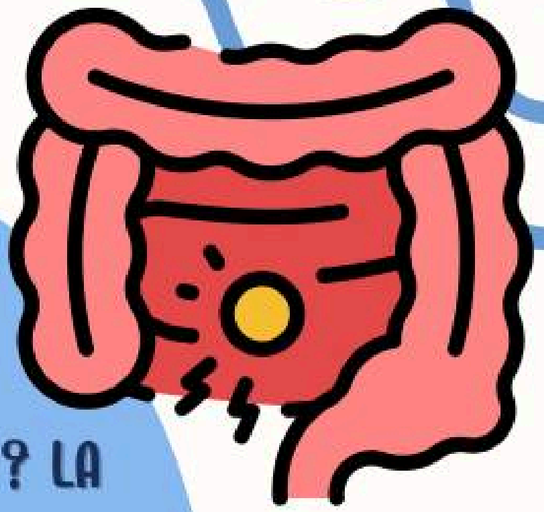


38) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LAQUELLE EST FAUSSE ? LA LITHIASE BILIAIRE EST :

A - LA PLUPART DU TEMPS CONSTITUÉE DE CHOLESTÉROL
B - PLUS FRÉQUENTE CHEZ LA FEMME
C - FAVORISÉE PAR UNE ALIMENTATION RICHE EN SEL.
D - FAVORISÉE PAR UNE PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE
E - ASYMPTOMATIQUE DANS 20% DES CAS

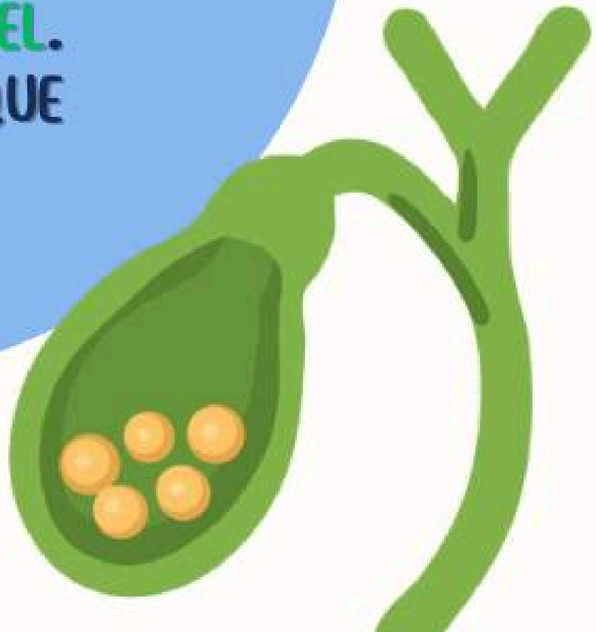






38) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LAQUELLE EST FAUSSE ? LA LITHIASE BILIAIRE EST :

A - LA PLUPART DU TEMPS CONSTITUÉE DE CHOLESTÉROL
B - PLUS FRÉQUENTE CHEZ LA FEMME
C - FAVORISÉE PAR UNE ALIMENTATION RICHE EN SEL.
D - FAVORISÉE PAR UNE PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE
E - ASYMPTOMATIQUE DANS 20% DES CAS



LES EXAMENS PRÉVALENTS







39) LES COMPLICATIONS SUITE À UNE CORONAROGRAPHIE SONT :

A - L'INFECTION
B - L'INSUFFISANCE RÉNALE
C - LA DOULEUR THORACIQUE
D - L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE
E - L'HÉMORRAGIE AU POINT DE PONCTION VASCULAIRE
F - AVC
G - TROUBLE DU RYTHME







39) LES COMPLICATIONS SUITE À UNE CORONAROGRAPHIE SONT :

A - L'INFECTION
B - L'INSUFFISANCE RÉNALE
C - LA DOULEUR THORACIQUE
D - L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE
E - L'HÉMORRAGIE AU POINT DE PONCTION VASCULAIRE
F - AVC
G - TROUBLE DU RYTHME







40) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LAQUELLE EST FAUSSE? LA CORONAROGRAPHIE EST :

A - RÉALISABLE EN UTILISANT L'ARTÈRE FÉMORALE & RADIALE
B - PEUT-ÊTRE RÉALISÉE DANS UN BUT THÉRAPEUTIQUE
C - INDIQUÉE EN CAS DE DOULEUR THORACIQUE
D - PEUT ÊTRE COMPLIQUÉE D'INSUFFISANCE HÉPATIQUE
E - SUIVIE D'UNE SURVEILLANCE IMPORTANTE EN SALLE DE RÉVEIL







40) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LAQUELLE EST FAUSSE? LA CORONAROGRAPHIE EST :

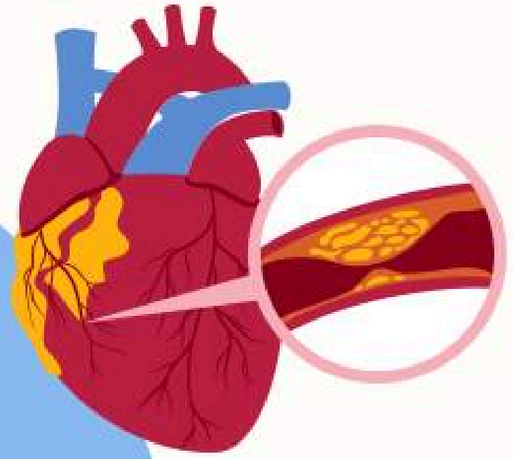
A - RÉALISABLE EN UTILISANT L'ARTÈRE FÉMORALE & RADIALE
B - PEUT-ÊTRE RÉALISÉE DANS UN BUT THÉRAPEUTIQUE
C - INDIQUÉE EN CAS DE DOULEUR THORACIQUE
D - PEUT ÊTRE COMPLIQUÉE D'INSUFFISANCE HÉPATIQUE
E - SUIVIE D'UNE SURVEILLANCE IMPORTANTE EN SALLE DE RÉVEIL





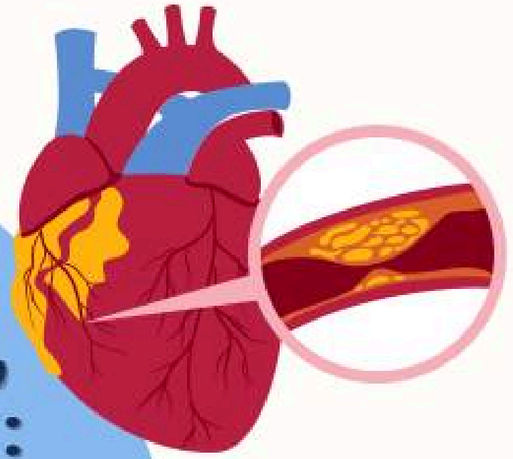


FACTEURS DE RISQUES CARDIO-VASC



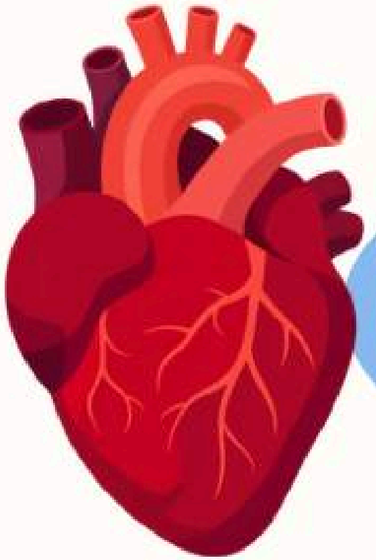




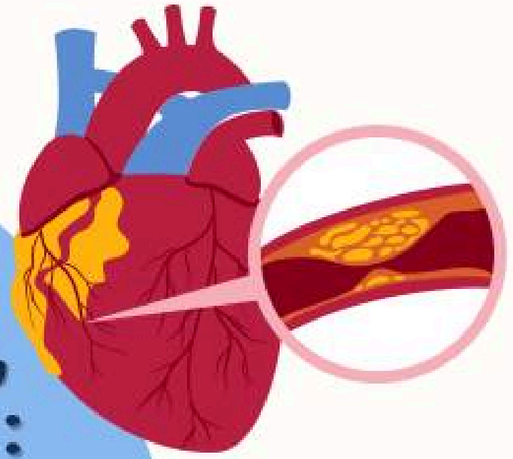


41) POUR UN PATIENT PRÉSENTANT UNE DYSLIPIDÉMIE, LES TRAITEMENTS QUI PEUVENT ÊTRE PRESCRITS SONT :

A - UN HYPOKALIÉMIANT
B - UN RÉGIME PAUVRE EN GRAISSE
C - UN INHIBITEUR CALCIQUE
D - UN HYPOLIPIDÉMIANT
E - UN BÊTABLOQUANT







41) POUR UN PATIENT PRÉSENTANT UNE DYSLIPIDÉMIE, LES TRAITEMENTS QUI PEUVENT ÊTRE PRESCRITS SONT :

A - UN HYPOKALIÉMIANT

B - UN RÉGIME PAUVRE EN GRAISSE

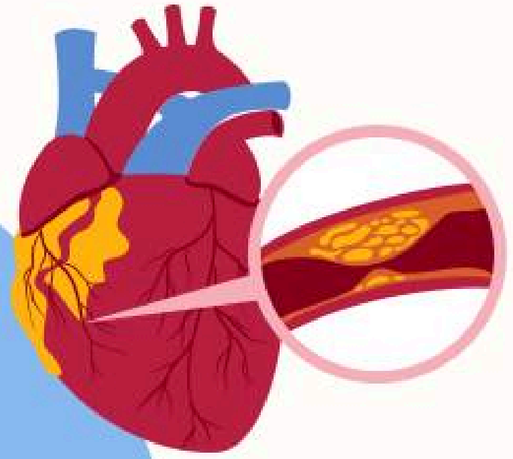
C - UN INHIBITEUR CALCIQUE

D - UN HYPOLIPIDÉMIANT

E - UN BÊTABLOQUANT





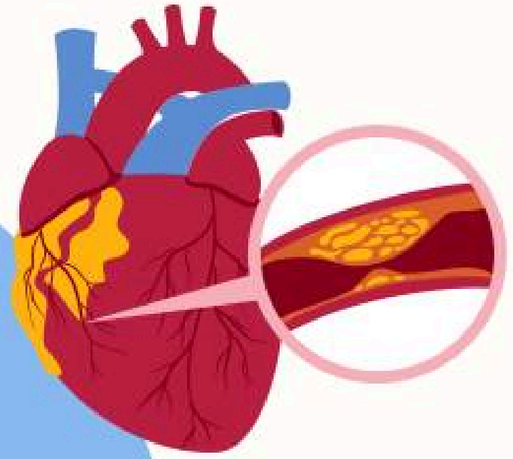


42) LES FACTEURS DE RISQUES PRÉDISPOSANTS CARDIOVASCULAIRES SONT :

A - L'HÉRÉDITÉ CARDIO VASCULAIRE
B - L'ÂGE
C - L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE
D - LA SÉDENTARITÉ
E - LE SEXE





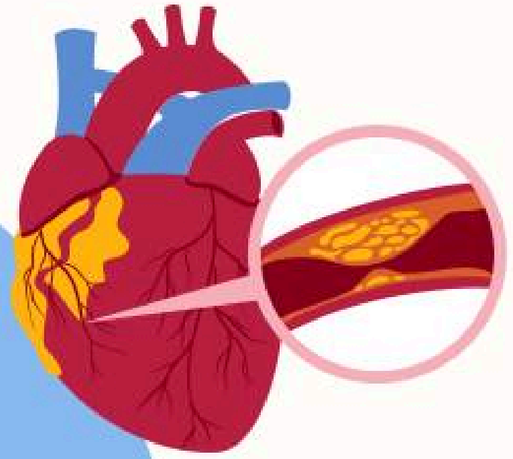


42) LES FACTEURS DE RISQUES PRÉDISPOSANTS CARDIOVASCULAIRES SONT :

A - L'HÉRÉDITÉ CARDIO VASCULAIRE
B - L'ÂGE
C - L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE
D - LA SÉDENTARITÉ
E - LE SEXE





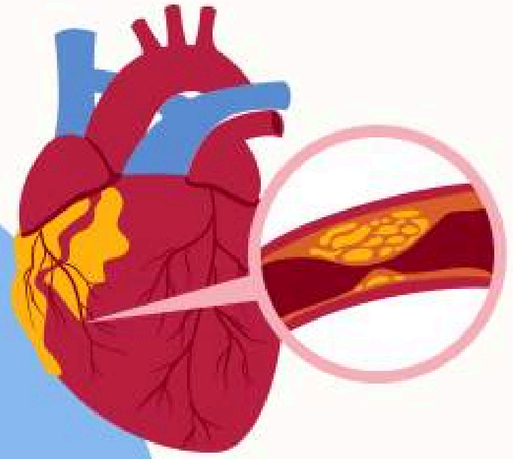


43) LES FACTEURS DE RISQUES PRÉCIPITANTS CARDIOVASCULAIRES SONT :

A - L'HÉRÉDITÉ CARDIO VASCULAIRE
B - L'HYPERCHOLESTÉROLÉMIE
C - L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE
D - LA SÉDENTARITÉ
E - LE TABAGISME







43) LES FACTEURS DE RISQUES PRÉCIPITANTS CARDIOVASCULAIRES SONT :

A - L'HÉRÉDITÉ CARDIO VASCULAIRE

B - L'HYPERCHOLESTÉROLÉMIE

C - L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

D - LA SÉDENTARITÉ

E - LE TABAGISME



QROC !!!!!!!!!!!

1) CITEZ 6 FACTEURS DE RISQUES DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE.

- TABAGISME
- HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HTA)
- DIABÈTE
- DYSLIPIDÉMIE
- OBÉSITÉ
- ANTÉCÉDENT FAMILIAL DE MALADIE CARDIOVASCULAIRE
- ÂGE
- STRESS
- SÉDENTARITÉ

- 2) LESQUELS SONT DES FACTEURS PRÉCIPITANTS ET PRÉDISPOSANTS?

- PRÉDISPOSANTS: AGE, HÉRÉDITÉ/ATCD MALADIE CARDIOVASCULAIRE, SEXE, OBÉSITÉ
- PRÉCIPITANTS: SÉDENTARITÉ, HTA, DYSLIPIDÉMIE, TABAGISME, STRESS, OBÉSITÉ, DIABÈTE

3) ÉNUMÉREZ 4 SIGNES CLINIQUES QUI PEUVENT ÊTRE PRÉSENTS EN CAS DE THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) .

- DOULEUR AU MOLLET OU CUISSE
- ŒDÈME DU MEMBRE INFÉRIEUR
- ROUGEUR OU CHALEUR LOCALE
- SENSIBILITÉ À LA PALPATION
- SIGNE DE HOMANS (DOULEUR À LA DORSIFLEXION)
- PERTE DU BALLOTTEMENT DU MOLLET

4) NOMMEZ LES 5 MESURES PRÉVENTIVES ESSENTIELLES DE LA MALADIE THROMBOEMBOLIQUE EN POSTOPÉRATOIRE RELEVANT DU RÔLE PROPRE ET DU RÔLE PRESCRIT.

- MOBILISATION PRÉCOCE ET MOBILISATION PASSIVE SI NÉCESSAIRE
- PORT DE BAS DE CONTENTION
- SURVEILLANCE DE LA PEAU ET DU MEMBRE INFÉRIEUR
- ADMINISTRATION D'ANTICOAGULANTS PRESCRITS (HBPM OU AVK)
- HYDRATATION ADAPTÉE
- LEVER PRÉCOCE
- SURÉLÉVATION DES MI

5) EXPLIQUEZ ET ARGUMENTEZ LES MARQUEURS SUIVANTS : BNP NT-PROBNP, D-DIMÈRES, TROPONINE.

BNP / NT-PROBNP : PEPTIDES SÉCRÉTÉS PAR LE VENTRICULE EN RÉPONSE À UNE SURCHARGE DE PRESSION OU DE VOLUME → INDICATEURS D'INSUFFISANCE CARDIAQUE

D-DIMÈRES : FRAGMENTS DE FIBRINE DÉGRADÉE → UTILES POUR RÉCUSER UNE TVP OU UNE EMBOLIE PULMONAIRE SI NÉGATIF

TROPONINE : ENZYME MYOCARDIQUE SPÉCIFIQUE → ÉLÉVATION PROPORTIONNELLE À LA NÉCROSE MYOCARDIQUE (IDM)

6) INDIQUEZ À QUOI CORRESPOND UNE DOULEUR RÉTROSTERNALE, CONSTRICTIVE, IRRADIANT À LA MÂCHOIRE ET AU MEMBRE SUPÉRIEUR GAUCHE QUI NE CÈDE PAS À LA PRISE DE TRINITRINE.

SIGNE TYPIQUE D'INFARCTUS DU MYOCARDE (IDM) → URGENCE MÉDICALE, NÉCESSITE HOSPITALISATION ET PRISE EN CHARGE URGENTE

7) INDIQUEZ À QUOI CORRESPOND UNE DOULEUR RÉTROSTERNALE, CONSTRICTIVE, IRRADIANT À LA MÂCHOIRE ET AU MEMBRE SUPÉRIEUR GAUCHE QUI CÈDE À LA PRISE DE TRINITRINE.

SIGNE TYPIQUE D'ANGOR STABLE (ANGINE DE POITRINE)
→ ISCHÉMIE MYOCARDIQUE RÉVERSIBLE

8) QU'EST CE QUE LA TRIADE DE CHARCOT ?

- FIÈVRE
- DOULEUR ABDOMINALE (HYPOCHONDRE DROIT)
- ICTÈRE

→ C'EST LA TRIADE TYPIQUE D'UNE ANGIOCHOLITE

9) EXPLIQUEZ LA TRIADE DE VIRCHOW

- STASE VEINEUSE
- LÉSION DE LA PAROI VASCULAIRE
- HYPERCOAGULABILITÉ

→ ENSEMBLE FAVORISANT LA FORMATION D'UN THROMBUS

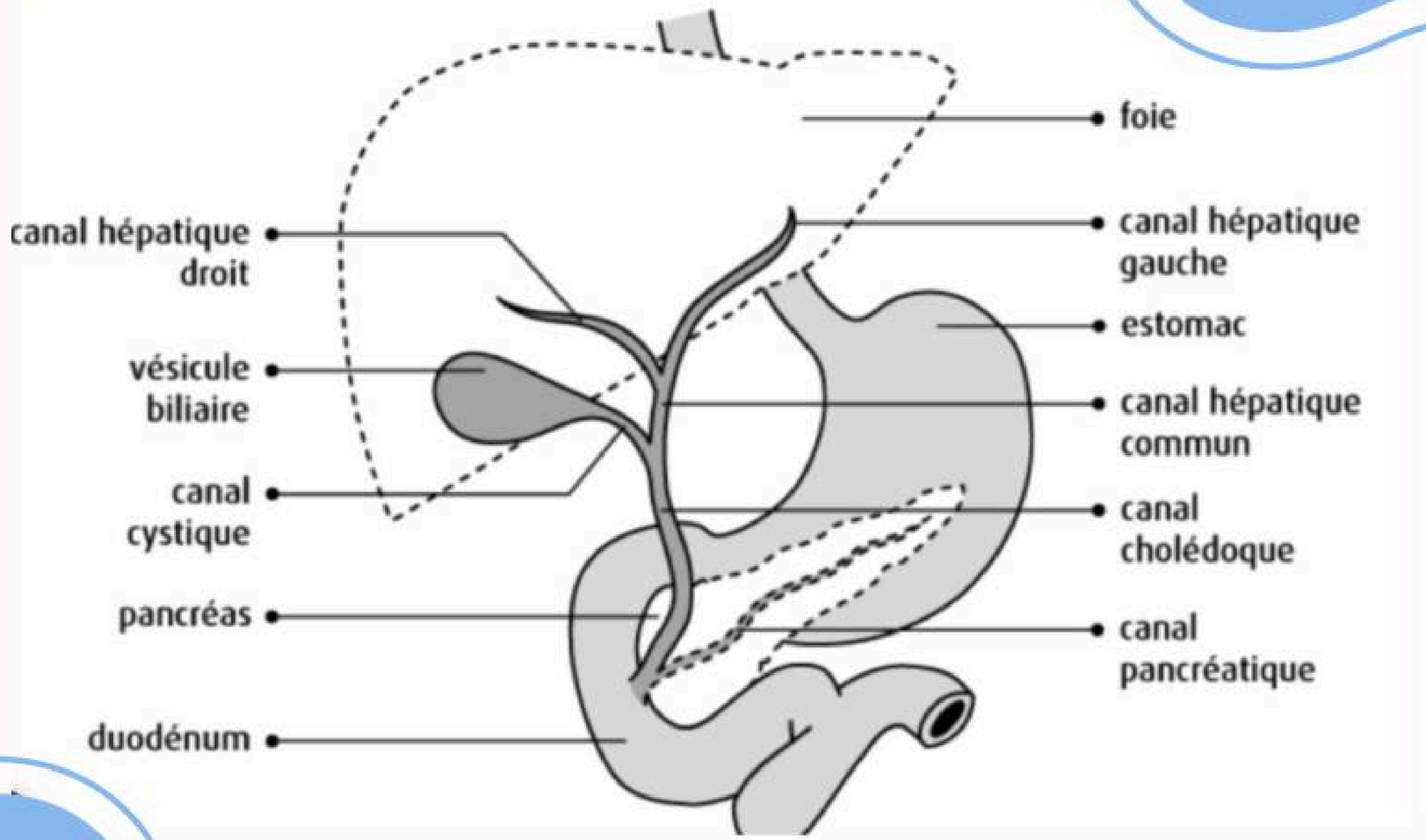
10) UNE ALIMENTATION RICHE EN SEL EST DANGEREUSE CHEZ UNE PERSONNE AYANT DÉJÀ EU UN OAP CARDIOGÉNIQUE :

A - VRAI
B - FAUX
ARGUMENTER VOTRE RÉPONSE CHOISIE.

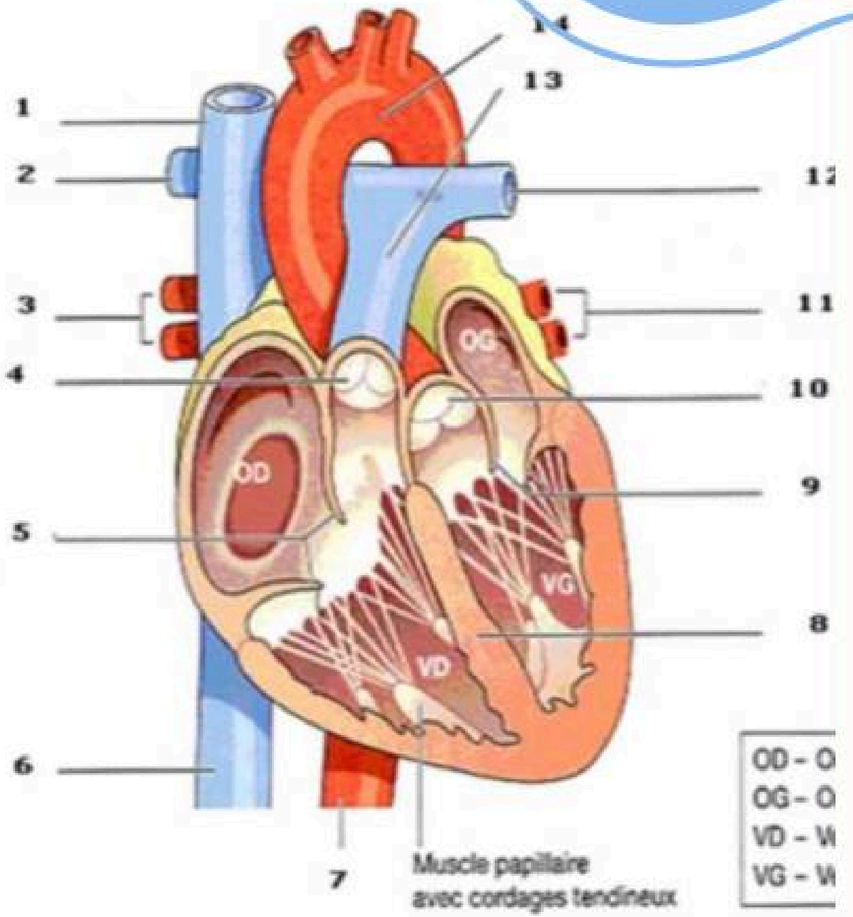
LE SEL FAVORISE LA RÉTENTION HYDROSODÉE → AUGMENTATION DU VOLUME SANGUIN ET DE LA PRESSION CAPILLAIRE PULMONAIRE → RISQUE DE RÉCIDIVE D'OAP

11) QU'EST-CE QUE LE SIGNE DE MURPHY ?

DOULEUR VIVE À L'INSPIRATION LORS DE LA PALPATION DU POINT DE LA VÉSICULE BILIAIRE (HYPOCHONDRE DROIT) QUI VA BLOQUER L'INSPIRATION→ SIGNE CLINIQUE D'UNE CHOLÉCYSTITE AIGUË


foie
canal hépatique droit
canal hépatique gauche
estomac
vésicule biliaire
canal hépatique commun
canal cystique
canal cholédoque
pancréas
canal pancréatique
duodénum

/eine cave supérieure
artère pulmonaire droite
/eines pulmonaires droites
/alve pulmonaire
/alve auriculo ventriculaire droite ou atrio
triculaire droite ou valve tricuspide
/eine cave inférieure
aorte
septum
/alve atrio ventriculaire gauche ou auriculc
triculaire gauche ou valve mitrale
valve aortique
veines pulmonaires gauches
artère pulmonaire gauche
artère pulmonaire ou tronc artériel
monaire
arc ou crosse aortique



BON COURAGE !!!